

2025年中国银发经济研究报告

——老龄化带动需求增长，养老服务日趋多元

概览标签：银发经济、老龄化、养老服务、居家养老、社区养老、机构养老、养老金融、养老保险、个人养老金制度、养老地产、医疗保健、智慧养老、“9073”模式、老年旅游、老年教育



行行查官网 — www.hanghangcha.com



行行查业务介绍 — 行业研究数据库



行行查数据产品 — 产业链图册



扫码获取

行行查公众号、小程序 — 扫码进入获取更多海量数据



行行查公众号

- ◆ **银发经济**：银发经济一词起源于20世纪70年代的日本，最初指的是为老年人提供的商品和服务。2024年初，国务院办公厅发布的《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》，银发经济被明确定义为“向老年人提供产品或服务，以及为老龄阶段做准备的一系列经济活动的总和”，具有涉及面广、产业链长、业态多元、潜力巨大的特点。
- ◆ **老龄化**：老龄化，也称为人口老龄化，是指一个国家或地区总人口中，老年人口（通常是指60岁及以上或65岁及以上的人口）所占的比重不断提高的动态过程。这反映了人口年龄结构的变化，即年轻人口数量相对减少，而老年人口数量相对增加，导致老年人口在总人口中的比例持续上升。
- ◆ **居家养老**：居家养老是一种以家庭为核心、社区为依托、专业化服务为支撑的养老模式，强调老年人在熟悉的生活环境中获得社会化养老服务。据卫健委数据，我国养老呈“9073”格局，即90%左右的老年人居家养老、7%左右的老年人依托社区支持养老、3%的老年人入住机构养老。
- ◆ **社区养老**：社区养老是一种将家庭养老和机构养老优势相结合的养老模式，它以社区为依托，为老年人提供包括生活照料、心理支持、整体关怀等在内的多种养老服务，让老年人在熟悉的社区环境中继续得到家人照顾的同时，也能享受到社区提供的专业养老服务。
- ◆ **机构养老**：机构养老则是指老年人居住在养老院、敬老院等专业的养老机构中，享受包括饮食起居、清洁卫生、生活护理、健康管理和文体娱乐活动等在内的综合性养老服务。这种养老模式由专业的机构进行规划和安排，为老年人提供全方位、全天候的照护服务。
- ◆ **养老金融**：养老金融是指综合运用信贷、保险、债券、股权、理财等金融工具，围绕社会成员的养老需求，提供养老金管理、养老服务金融和养老产业金融等综合性金融活动，旨在实现养老资产的保值增值，满足老年人多样化的金融需求，服务银发经济的发展。
- ◆ **养老地产**：养老地产是指专为老年人设计，集居住、医疗、护理、康复、娱乐等功能于一体，提供全方位养老服务的综合性房地产项目。它旨在满足老年人多样化的生活需求，提升老年人的生活质量。

- ◆ **帕金森病**：帕金森病是一种常见的中老年神经系统退行性疾病，以静止性震颤、运动迟缓、肌强直和姿势平衡障碍为主要特征，伴有睡眠障碍、嗅觉障碍等非运动症状，目前无法完全治愈，但早期治疗可显著改善患者生活质量。
- ◆ **阿尔茨海默病**：阿尔茨海默病是一种起病隐袭、持续进行性发展的神经退行性疾病，主要影响老年人的认知功能，表现为记忆障碍、失语、失用、失认、视空间能力损害、抽象思维和计算能力损害等，严重影响患者的日常生活和社会功能，目前尚无根治方法，治疗以延缓病情进展、提高生活质量为主。
- ◆ **高血压**：高血压是一种以体循环动脉血压持续升高为主要特征的心血管疾病，常伴有头痛、头晕、心悸等症状，长期高血压还可能导致心、脑、肾等靶器官损害，是心脑血管疾病最重要的危险因素之一。
- ◆ **养老保险**：养老保险是一种由国家和社会提供物质帮助，以保障劳动者在达到国家规定的解除劳动义务的劳动年龄界限或因年老丧失劳动能力后，能够依法获得稳定经济来源的社会保险制度。
- ◆ **个人养老金制度**：个人养老金制度是政府支持、个人自愿参与、市场化运作的补充养老保险制度，旨在通过个人账户积累资金并投资金融产品，为老年人提供额外的养老保障。个人养老金制度是对基本养老保险和企业（职业）年金的重要补充，旨在提高老年人的养老保障水平。

目录



01

◆ 银发经济产业概述

- 老龄化社会孕育的万亿市场机遇
- 我国已迈入“深度老龄化”社会



02

◆ 银发经济细分领域

- 养老服务：居家养老仍是我国的主要养老模式
社区养老、机构养老服务成为养老体系的重要补充
养老服务模式转型，居家/社区养老崛起
- 养老金融：养老金融是养老金融体系的核心部分
养老服务金融助力老年财富管理与生活保障
养老产业金融是银发经济发展的资本引擎
- 医疗保健：人均医保支出攀升，大健康成为市场发力点
阿尔兹海默症是常见的神经退行性疾病
我国老年人高血压患病形势不容乐观
- 老年用品：老年用品消费趋向多元化、高品质和健康化
- 养老地产：参与者多元，运营模式和盈利方式多样
- 文化娱乐：老年群体的精神文化消费需求日益提升



03

◆ 银发经济政策观点分析

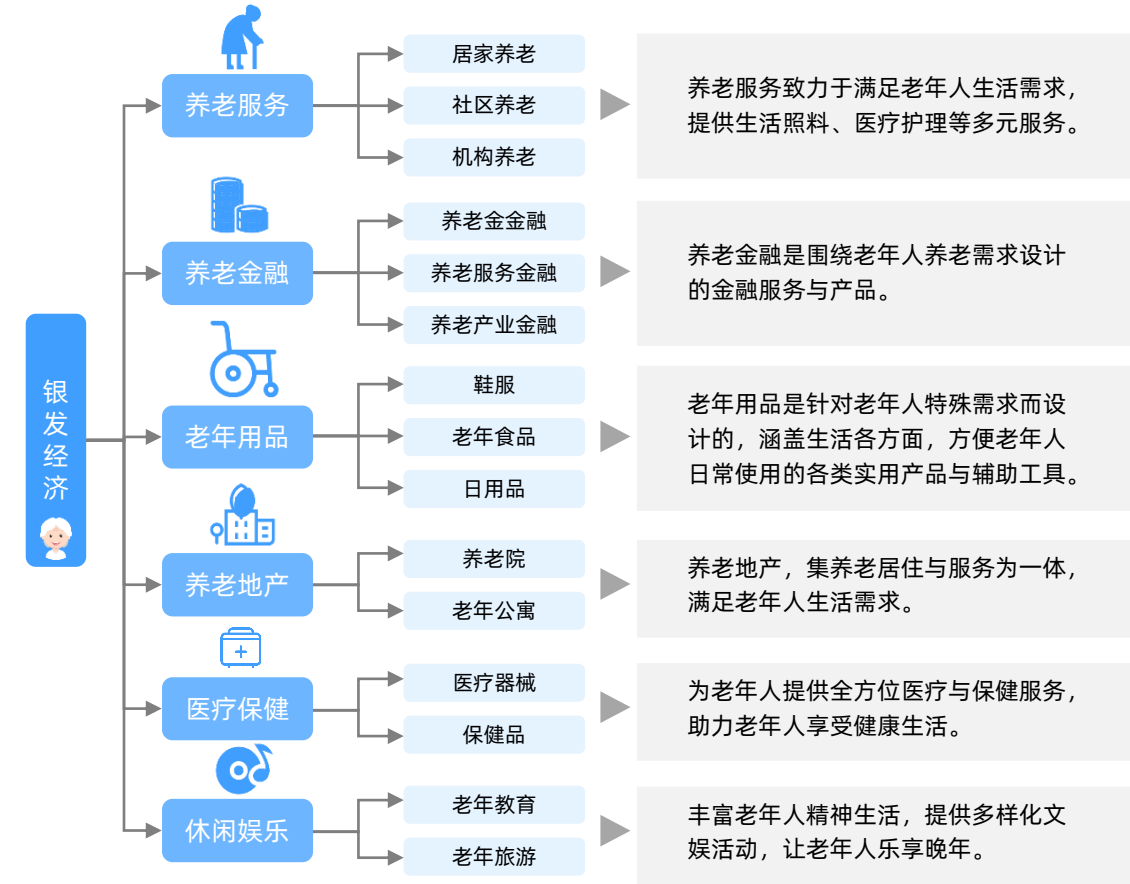
- 新时代老年人养老需求正发生转变
- 养老用品市场未被充分挖掘
- 国家大力推广个人养老金制度
- 日本银发经济对我国养老行业的借鉴意义



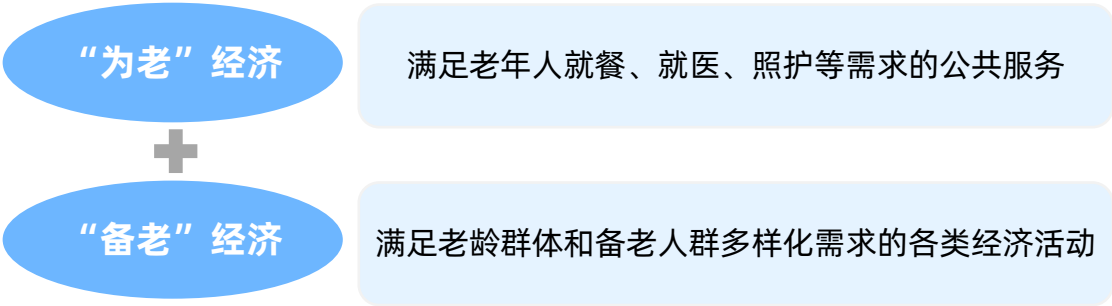
银发经济产业概述：老龄化社会孕育的万亿市场机遇

◆ **银发经济** 一词起源于20世纪70年代的日本，最初指的是为老年人提供的商品和服务。2024年，国务院发布的《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》，银发经济被明确定义为“向老年人提供产品或服务，以及为老龄阶段做准备的一系列经济活动的总和”，这也意味着，发展银发经济兼顾“为老”和“备老”两个维度，具有涉及面广、产业链长、业态多元、潜力巨大的特点。

银发经济主要包括六大板块



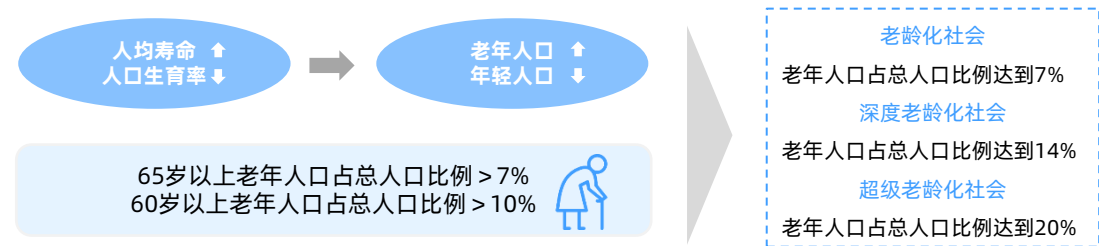
银发经济涵盖“为老”“备老”两个维度



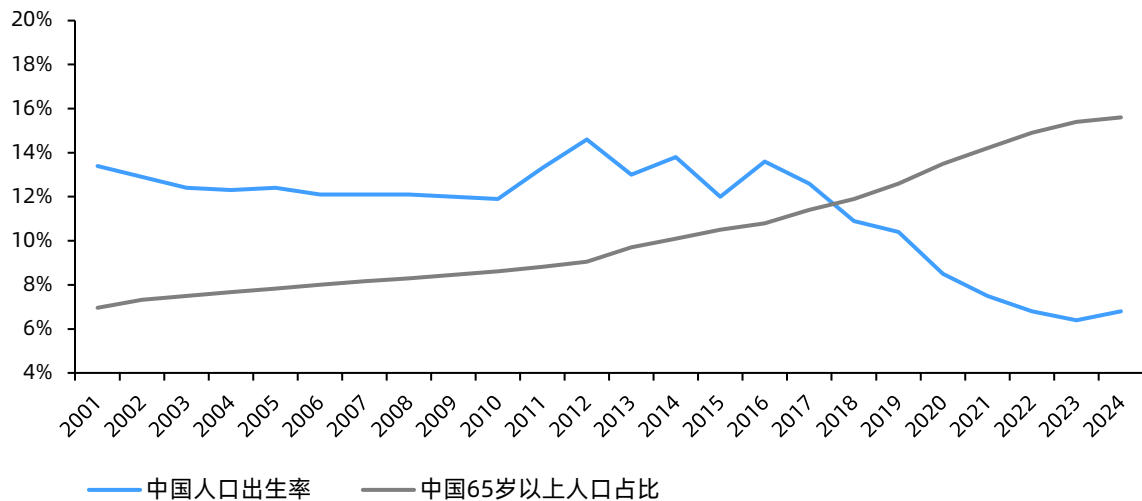
银发经济产业概述：我国已迈入“深度老龄化”社会（1/3）

◆ **人口老龄化** 是指一个国家或地区总人口中，老年人口（通常是指60岁及以上或65岁及以上的人口）所占的比重不断提高的动态过程。联合国老龄化标准为，当一个国家或地区65岁及以上人口占总人口比例超过7%，或者60岁及以上人口占总人口比例超过10%时，则意味着这个国家或地区进入老龄化。国家统计局数据显示，2024年新生儿954万，虽比2023年增加52万（受龙年生育意愿影响），但长期趋势仍在下降。我国人均寿命预期随着经济社会发展而不断提升，2024年我国的老年抚养比达22.5%（即每5个劳动力需抚养1名老人），较2005年（10.7%）翻倍，老龄化形势严峻！

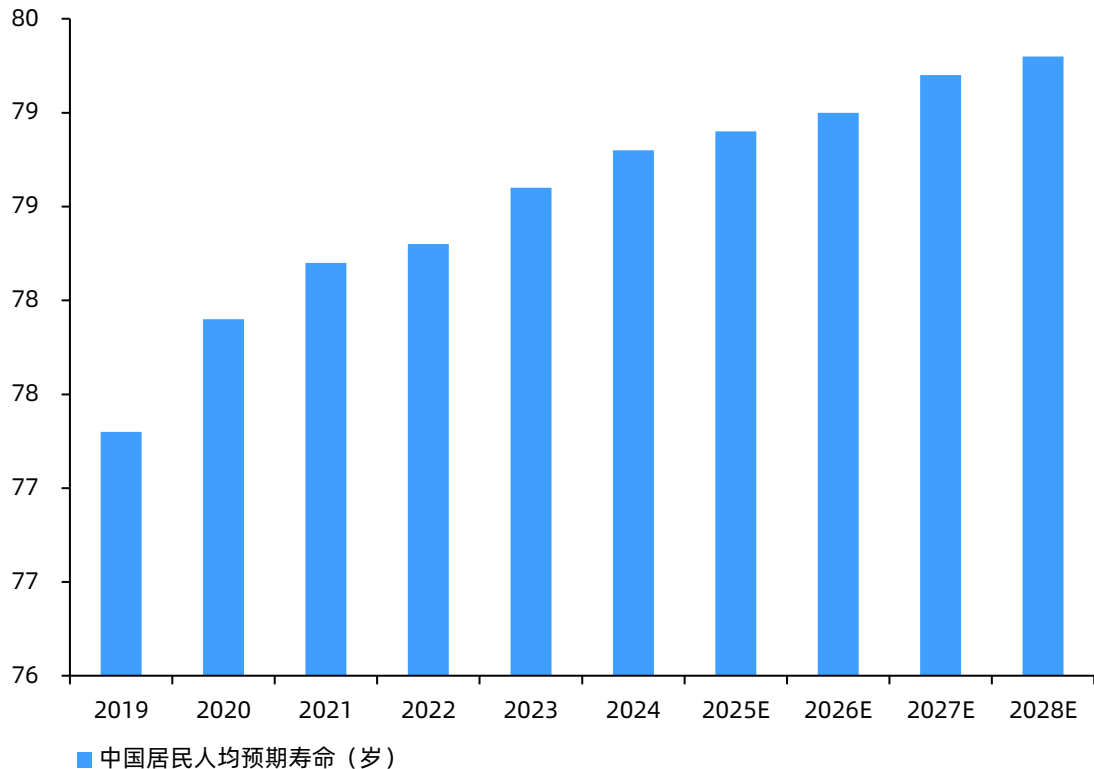
老龄化定义和标准



2001-2030年中国人口出生率及65岁以上人口占比



2019-2028年中国居民人均预期寿命

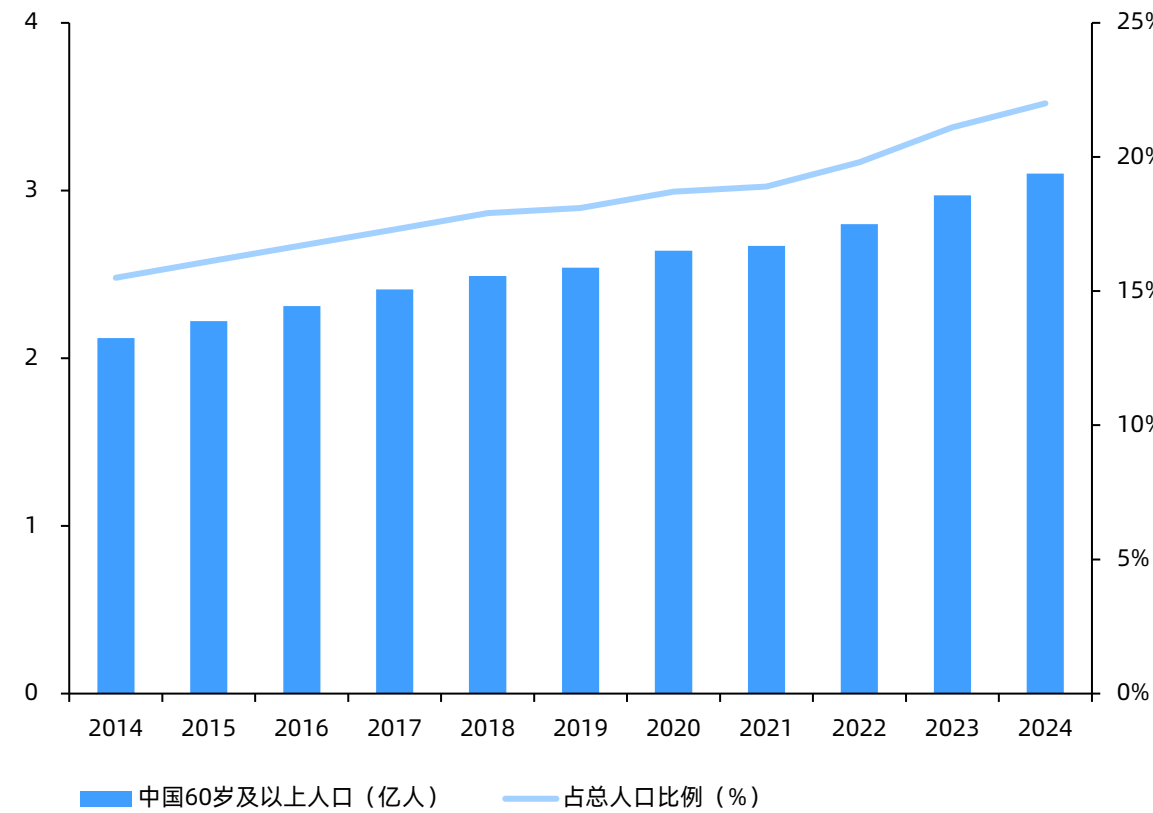


银发经济产业概述：我国已迈入“深度老龄化”社会（2/3）

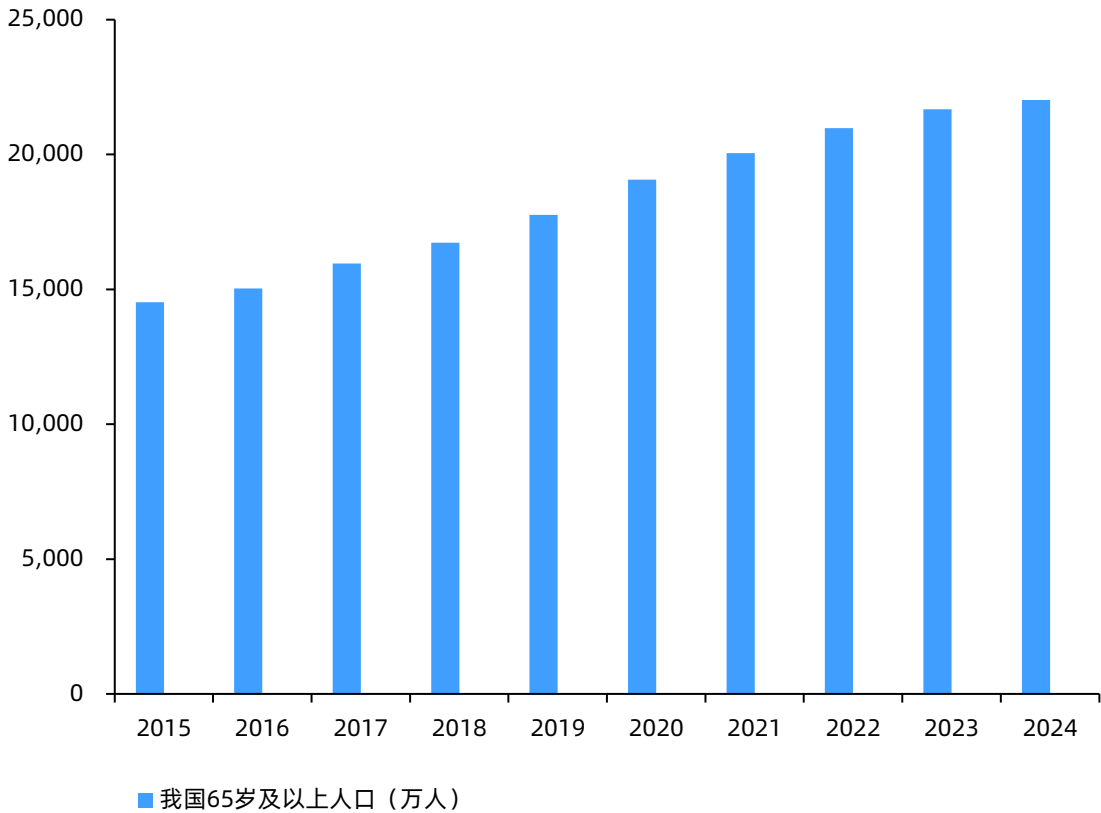


◆ 中国老龄化程度预计持续加深，银发经济市场空间广阔。国家统计局数据显示，2024年60岁及以上人口达3.1亿人，占全国人口的22.0%，其中65岁及以上人口2.2亿人，占全国人口的15.6%。据国家卫健委给出的数据，预计2035年前后，我国将有4亿左右60岁以上的老年人口，占比超过30%，到本世纪中叶，预计将有5亿以上老人，比例超过40%。

2014-2024年中国60岁及以上人口数量及占比



2015-2024年中国65岁及以上人口数量



银发经济产业概述：我国已迈入“深度老龄化”社会（3/3）

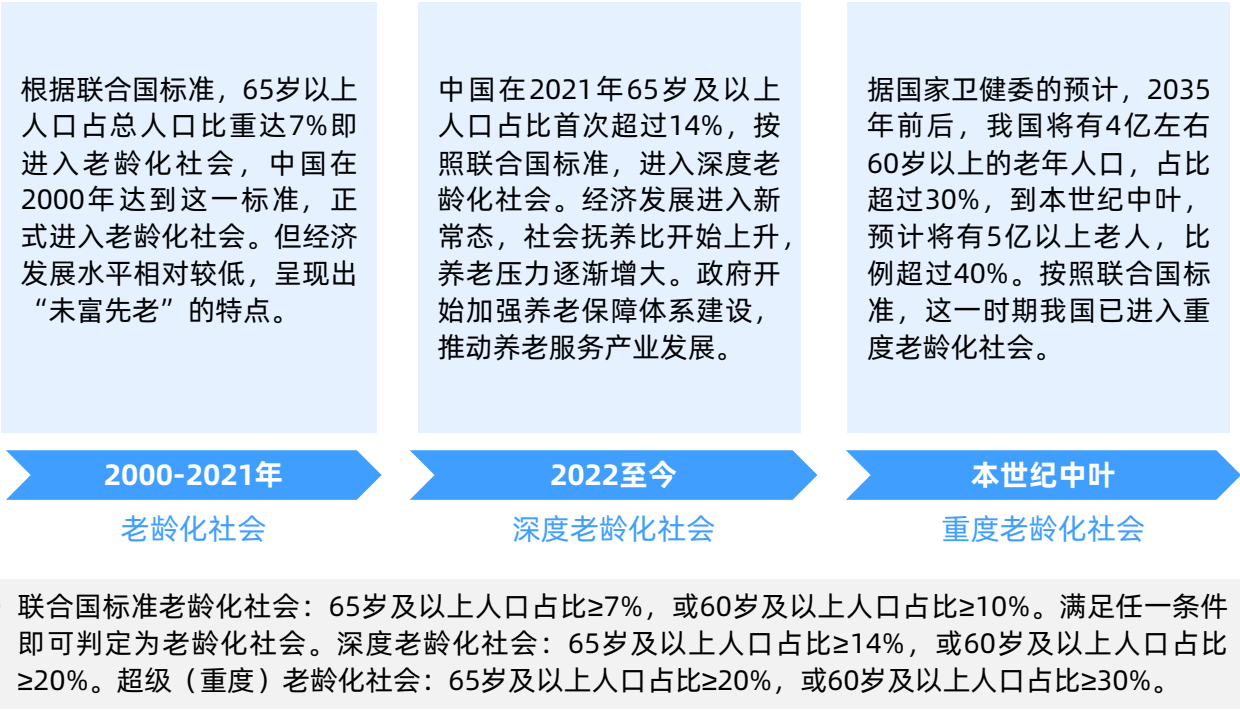


- ◆ 自第一次全国人口普查（1953年）至第七次全国人口普查（2020年），中国老年人口数量和占比呈现出明显的增长趋势。在第一次人口普查时，65岁及以上人口为2563万人，占总人口的4.40%；到第七次人口普查时，65岁及以上人口已达19064万人，占比13.50%。这些数据清晰地表明，中国老龄化程度在不断加深，且这一趋势具有长期性和不可逆性。
- ◆ 根据联合国标准，65岁以上人口占总人口比重达7%即进入老龄化社会，中国在2000年达到这一标准，正式进入老龄化社会。而当一个国家或地区65岁及以上老年人口占比超过14%，则进入深度老龄化社会。民政部数据显示，中国在2021年左右，65岁及以上人口占比首次超过14%（14.2%），已经进入深度老龄化社会。这一过程仅用约21年，速度快于最早进入老龄社会的法国和瑞典。

全国人口普查结果显示老龄化程度持续加剧

全国人口普查	普查标准时间	65岁及以上人口（万人）	人口占比
第一次	1953年6月30日	2563	4.40%
第二次	1964年6月30日	2500	3.60%
第三次	1982年7月1日	4940	4.90%
第四次	1990年7月1日	6461	5.60%
第五次	2000年11月1日	8811	7.00%
第六次	2010年11月1日	11883	8.90%
第七次	2020年11月1日	19064	13.50%

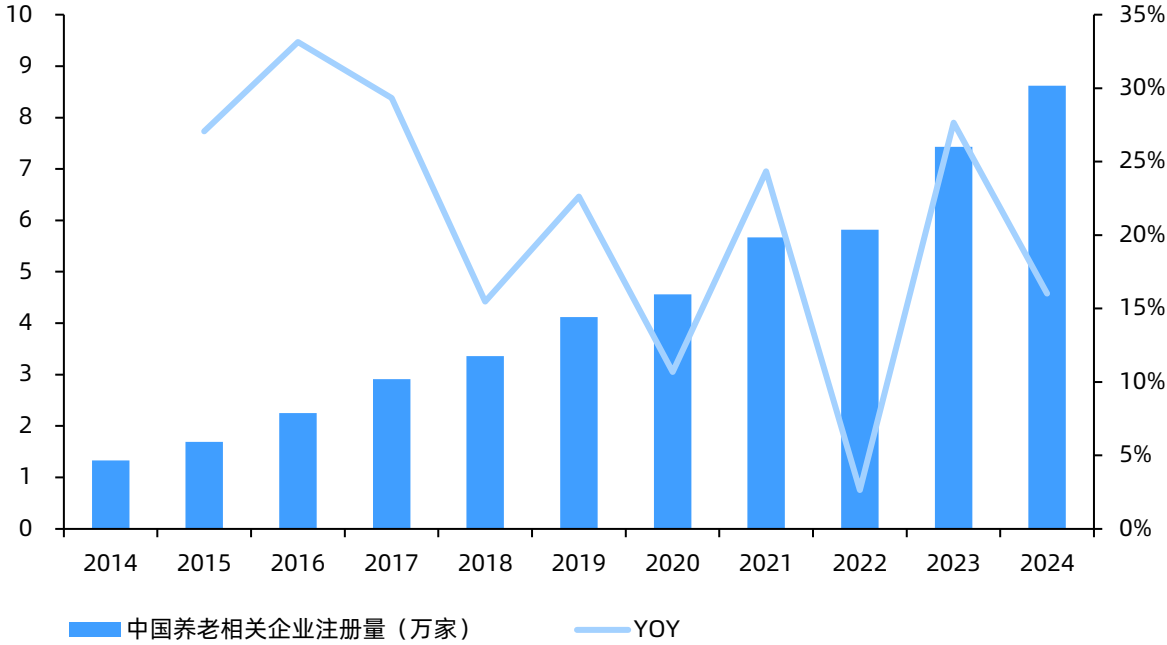
我国老龄化正步入加速发展阶段，老龄化问题日益凸显



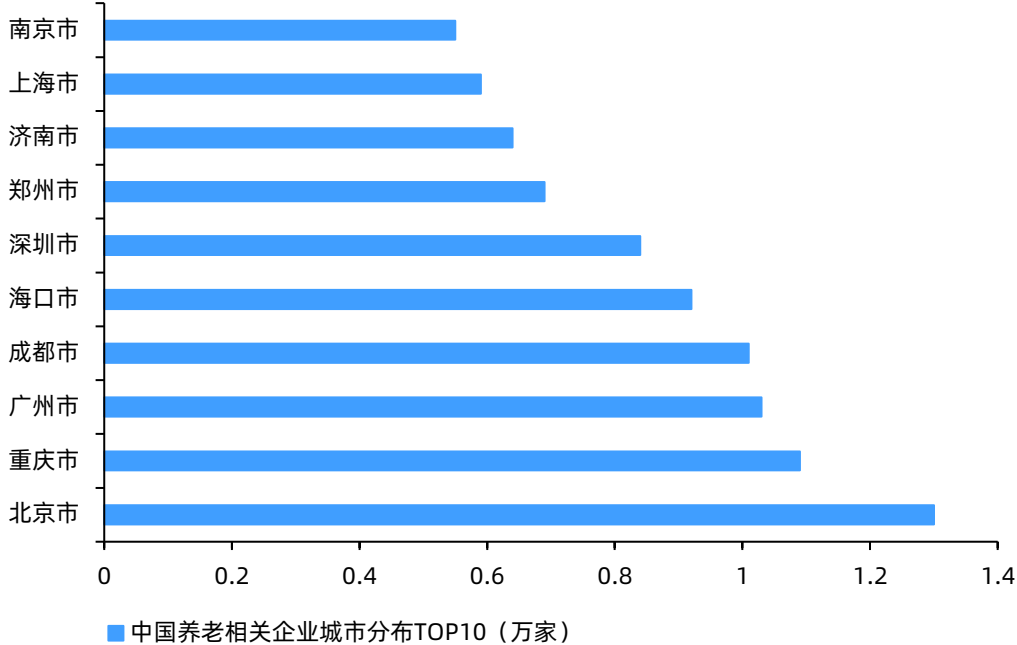
银发经济产业概述：中国养老产业处于加速扩张阶段

- ◆ 近十年，我国养老赛道新入主体规模日益壮大。企查查数据显示，我国现存38.4万家养老相关企业，2014年全年我国累计注册1.33万家养老相关企业，后每年注册量增速均保持正向增长。2023年全年累计注册7.43万家养老相关企业，是2014年全年的5倍有余，增速达2018年以来新高。2024年前五个月，我国已注册3.04万家养老相关企业，同比增加4%。
- ◆ 社会及公共资源正在投入到养老这个超级赛道，在各大城市相继进入深度老龄化社会后，GDP竞跑之外，养老服务发展水平将成为一座城市的核心竞争力。从区域分布上，山东、江苏成为全国相关企业存量“唯二”超过3万家的区域，广东排名前三，此后依次为四川、河南、安徽等地。从城市分布上，高能级省会城市养老相关企业存量更多。北京现存1.3万家养老相关企业，断层第一，重庆、广州、成都分别现存1.09万家、1.03万家、1.01万家，排名前三。此后依次为海口、深圳、郑州等地，相关企业存量在1万家以内。

2014-2024年中国养老相关企业注册量及增速



2024年中国养老相关企业城市分布TOP10



银发经济产业概述：多数发达国家已进入中、深度老龄化社会

- ◆ 全球主要高收入经济体已相继进入老龄化社会，日本是亚洲首个进入老龄化社会的国家。根据世界银行统计，2024年全球65岁及以上人口占比约为10.5%。摩纳哥、日本、意大利老龄化居全球前三，2024年65岁及以上人口占比分别为36%、30%、24%左右。中国老龄化排名为第74名，2024年，中国65岁及以上人口占比为15.6%，高于全球10%的平均水平。
- ◆ 全球多数发达国家已进入中、深度老龄化社会，与欧美国家相比，亚洲国家老龄化速度明显较快，表明中国将比欧洲和北美的发达国家更早面临老龄化社会的挑战，社会需要提前关注并做好相关准备。

2024年全球部分国家的老龄化情况

国家/地区	65岁以上人口占比
摩纳哥	约36%
日本	约30%
意大利	约24%
芬兰	23%
葡萄牙	23%
希腊	23%
保加利亚	22%
波多黎各	22%
德国	22%
中国	15.6%

多数西方国家已进入中、深度老龄化社会



日本是全球老龄化最严重的国家，截至2024年，其老龄化率（65岁及以上人口占比）为29.3%，已经进入超高龄社会。



美国2024年65岁以上人口占总人口的比例约为17%-18%，已进入中度老龄化社会，老龄化速度较欧洲和日本缓慢。



德国2024年65岁及以上人口占比约为22.5%，也是欧洲老龄化最严重的国家之一，已进入深度老龄化社会。



英国2024年65岁及以上人口占比约19%。英国老龄化程度较高，但相比德、意稍轻，仍处于中度老龄化阶段。



法国2024年65岁及以上人口占比约 21.1%，老龄化程度相比德国和意大利稍缓和，得益于相对较高的生育率（1.8左右）。



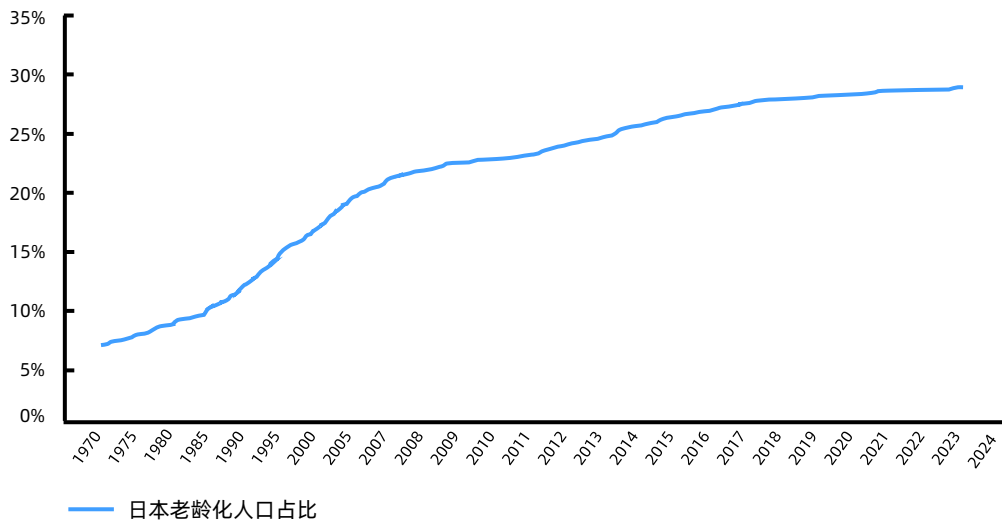
意大利2024年65岁及以上人口占比约为24%。意大利是全球老龄化最严重的国家之一，仅次于日本，已进入超老龄社会。

银发经济产业概述：日本老龄化程度近30%，远超其他发达国家

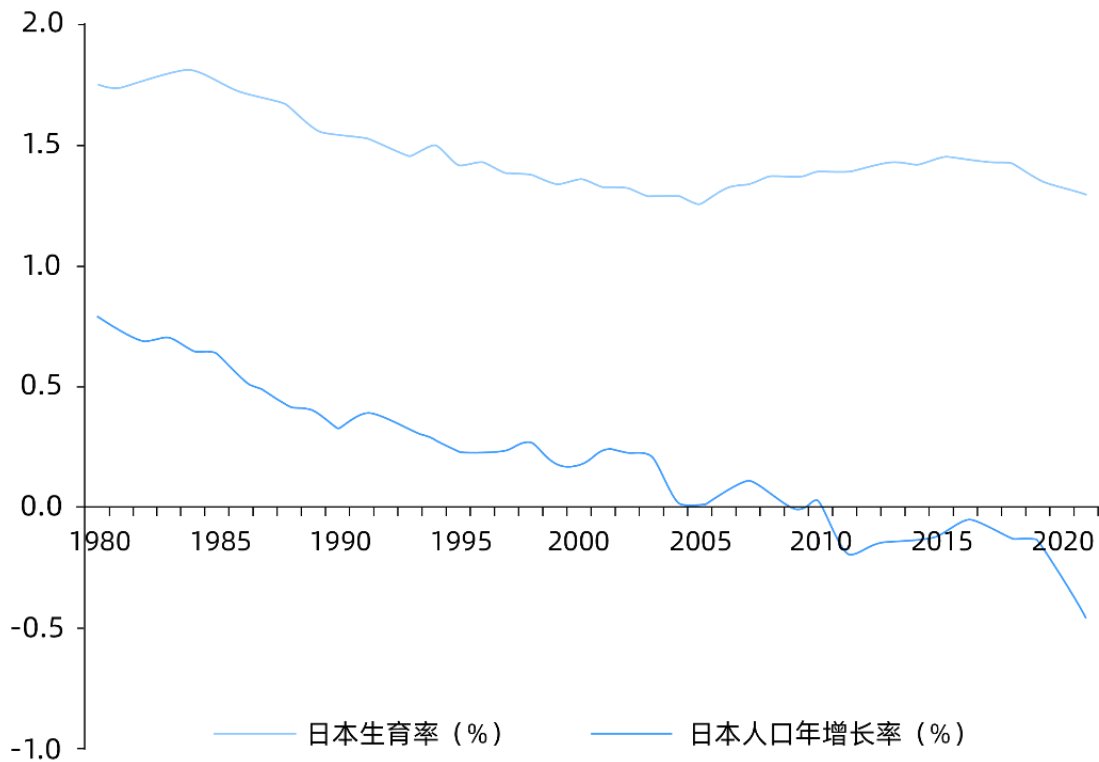


- ◆ 日本总务省统计显示，1971年，日本65岁及以上人口占比达到7.05%，标志着日本进入老龄社会。1995年，日本65岁及以上人口占比突破14%，进入深度老龄社会。2004年，日本65岁及以上人口占比突破20%，步入超级老龄社会。截至2022年底，日本65岁以上的老年人有3744万人，老龄化率高达29.92%，远超其余发达国家的老龄化程度（美国为17.13%，德国为22.41%）。日本总务省的数据显示，截至2024年9月15日的65岁以上老人的推算人口同比增长2万人至3625万人，创历史新高。其在总人口中的占比也同比增长0.2个百分点至29.3%，同样创出历史新高。
- ◆ 引发日本老龄化持续加剧的两大原因：长寿+少子化。一方面，医疗技术显著进步、居民收入水平的稳步提升以及健康意识的普遍增强，推动了人均预期寿命的持续增长。目前，日本在平均预期寿命方面已跻身世界前列，据2021年日本的平均预期寿命报告显示，女性为87.57岁，男性为81.47岁。另一方面，晚婚、不婚趋势日益明显，加之经济压力等多重因素影响，导致民众生育意愿不断降低。自2011年起，日本已连续十余年陷入人口负增长困境。

1970-2023年日本老龄化人口占比



2011年起，日本已出现连续十余年的人口负增长



银发经济产业概述：对比日本，中国的老龄化会有哪些不同



- ◆ 日本银发经济的发展，以人口老龄化和石油危机为重要契机，在20世纪70至80年代主要聚焦于银发服务领域。自1973年起，发展重心逐步转向住宅相关服务和居家支援服务。到了1995至2004年，银发服务概念逐渐演变为银发经济概念，银发产业迎来蓬勃发展。随着介护保险制度的实施和民间活动的积极参与，以介护经济为核心的银发经济备受关注，步入快速发展轨道。
- ◆ 进入超老龄社会后，日本人口自然增长率转为负值，总人口数开始减少。在此背景下，养老照护产业成为日本银发经济的重要组成部分，并逐渐成为刺激经济发展的主要动力。如今，以提供服务为主的银发服务和以生产制造业为主的银发产业，共同构成了银发经济市场的两大支柱。

中日老龄化情况对比

对比	日本	中国
经济背景	“边富边老”（人均GDP已超3万美元）	“未富先老”（人均GDP约1.35万美元）
老龄化开始时间	上世纪80年代末至90年代初	2020-2030年间开始显著影响创新活力
老年人口规模	老年人口超过3600万（2024年9月预测）	老年人口3.10亿（2024年）
家庭结构	独居老人占比高，家庭养老弱化	仍主要依赖家庭养老
老龄化群体财富	较高的动产或不动产，推动“银发经济”	老龄人口比重与养老服务供给倒挂，养老金覆盖不平衡
低生育率影响	长期负面影响逐渐显现，但过去已享受经济高速增长红利	长期负面影响将更加显著，未来可能面临经济增长停滞风险
应对老龄化策略	老龄者再就业率高，形成“老有所为”“老有所用”社会氛围	探索“教育红利”与“老龄红利”教育改革与适应老龄化趋势

可借鉴的日本养老政策的经验

构建多层次养老保障

- 参考日本介护保险的“政府+个人”共担模式，加快长期护理保险试点。
- 发展企业年金和商业养老保险，减轻基本养老金压力。

推动居家社区养老

- 推广“15分钟养老服务圈”，整合社区卫生中心与养老设施，提供医养结合服务。
- 引导物业、家政企业转型参与社区养老，借鉴日本“小规模多功能”设施经验。

优化劳动力政策

- 逐步延迟退休至65岁，建立弹性就业机制，开发适合老年人的轻体力岗位（如数字适老培训）。
- 消除就业年龄歧视，立法要求企业保留老年员工。

生育支持体系

- 加大育儿补贴力度（如延长产假、提高个税减免），试点“父母共同育儿假”。
- 扩大普惠托育服务，将幼儿园纳入义务教育。

社会协同机制

- 鼓励银发经济，发展老年旅游、教育等产业，培育专业化养老企业。
- 建立“时间银行”等互助养老模式，激活低龄老年人人力资源。

银发经济产业链：银发经济覆盖多元业态，产业链条长

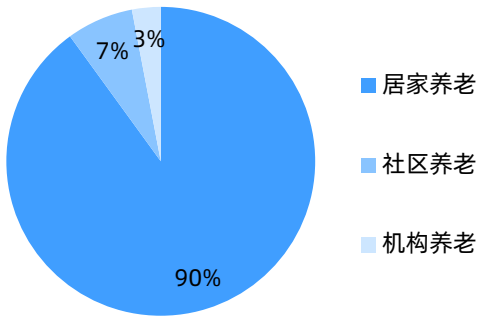
银发经济产业链图谱



银发经济养老服务：居家养老仍是我国的主要养老模式

◆ 居家养老是一种以家庭为核心、社区为依托、专业化服务为支撑的养老模式，强调老年人在熟悉的生活环境中获得社会化养老服务。据卫健委数据，我国养老呈“9073”格局，即90%左右的老年人居家养老、7%左右的老年人依托社区支持养老、3%的老年人入住机构养老。

我国养老呈现“9073”的格局



居家养老的服务形式



居家养老与机构养老的优劣势对比

对比	居家养老	机构养老
环境适应性	保留熟悉环境，减少心理落差	需适应新环境，可能引发孤独感
服务专业性	基础护理为主，复杂医疗需求依赖外部资源	提供24小时专业护理，适合失能/半失能老人
经济成本	隐性成本低（如住房），但长期护理可能增加家庭负担	显性费用较高，但规模化服务降低边际成本
社会关系	维持家庭纽带，但独居老人易陷入社交孤立	集体生活促进同龄社交，但削弱家庭互动

中国居家养老代表性企业



● 这些企业各自在居家养老服务领域具有显著的优势和特色，通过不断创新和优化服务模式，为居家养老的老年人提供了多样化的服务选择和服务内容，满足老年人的个性化需求，提高他们的生活质量。

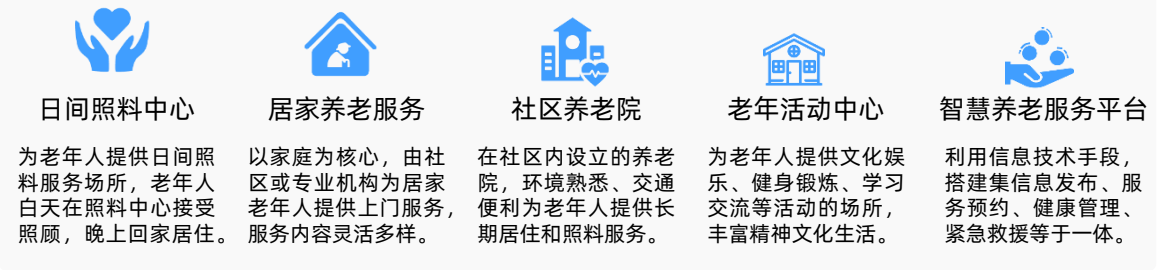
银发经济养老服务：社区养老、机构养老服务成为重要补充

◆在老龄化社会加速到来的当下，社区养老与机构养老服务正逐步成为我国养老体系中的重要补充力量。社区养老依托社区资源，为老年人提供便捷、贴心的日间照料、康复护理、文化娱乐等服务，让老人在熟悉的环境中安享晚年，既满足了他们的情感需求，又减轻了家庭养老负担。机构养老则凭借专业的护理团队、完善的设施设备和多样化的服务项目，为失能、半失能老人以及有更高养老需求的老人提供全方位、个性化的照护。这两种养老模式相互补充、协同发展，有效缓解了家庭养老的压力，提升了老年人的生活质量，为我国应对人口老龄化挑战、构建多层次养老服务体系提供了坚实支撑。

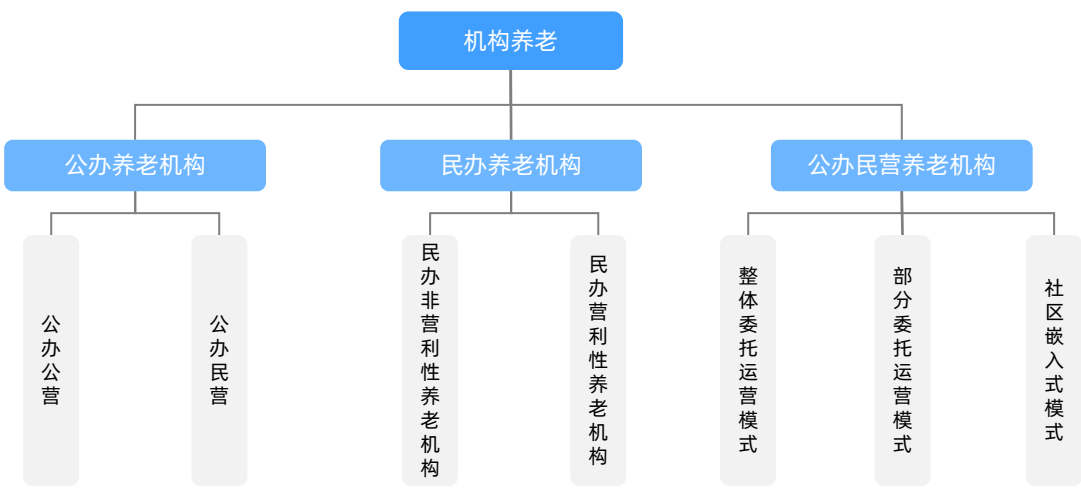
社区养老与机构养老的对比

维度	社区养老	机构养老
生活环境熟悉度	老年人可留在家中或社区，保持原有社交关系	需适应新环境，可能面临社交关系重建
成本	依托现有资源，成本较低	设施、人力投入大，费用较高
服务个性化程度	可定制上门服务，满足多样化需求	标准化服务为主，部分高端机构提供个性化方案
医疗支持	依赖社区医疗资源，对失能老人支持有限	配备专业医疗团队，适合失能、术后康复等复杂需求
情感维系	家庭参与度高，减少孤独感	可能因脱离家庭环境导致情感疏离
资源整合	整合社区资源，但存在服务碎片化风险	集中化管理，资源调配效率高
适用人群	自理能力较强、需轻度照护的老年人；希望维持家庭联系和社区社交的老人	失能失智、需全天候护理的老人；家庭照护资源不足或子女无法承担压力的家庭

社区养老的服务形式



机构养老分类

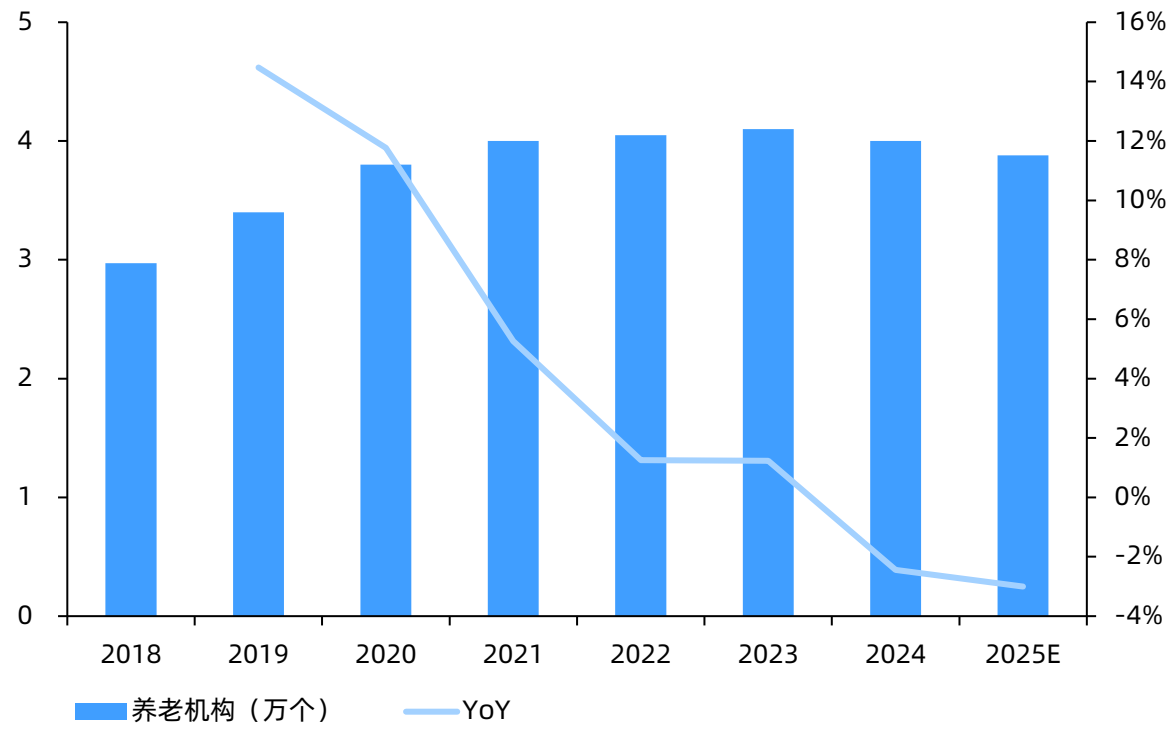


银发经济养老服务：养老服务模式转型，居家/社区养老崛起

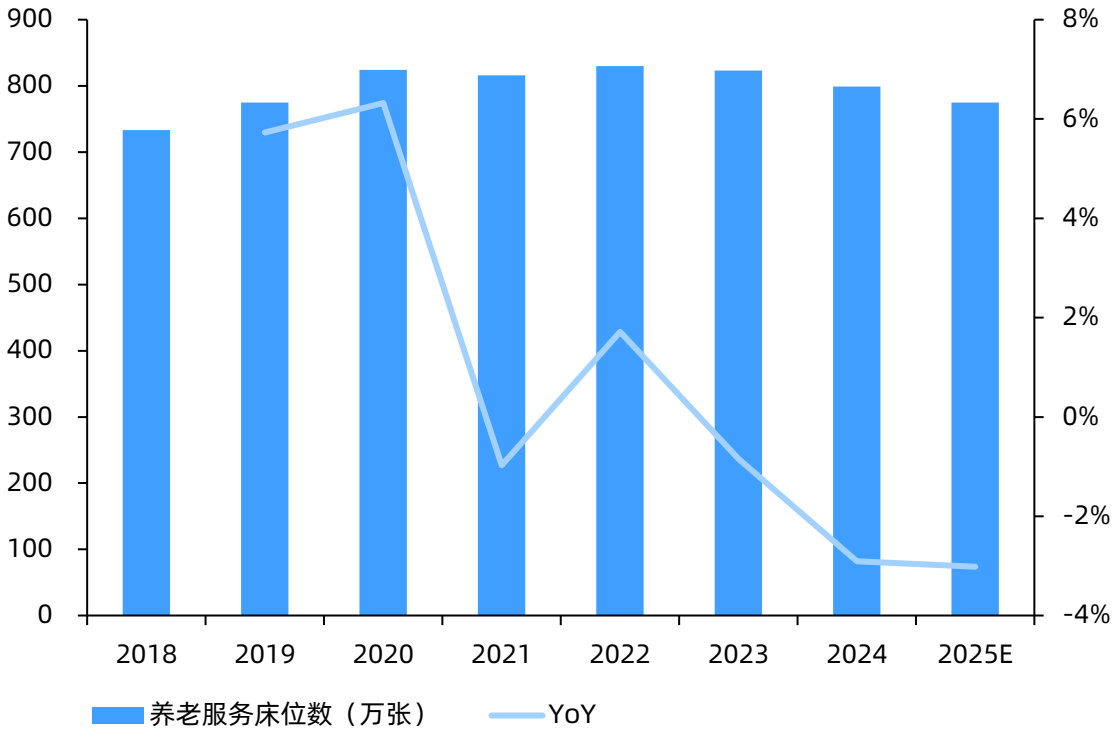


◆ 民政部数据显示，2024年末全国共有各类提供住宿的民政服务机构4.3万个，其中养老机构4.0万个。民政服务床位825.3万张，其中养老服务床位799.1万张。近年来，我国的注册登记养老机构数量与养老服务床位数量呈逐年递减的趋势。这与国家鼓励居家养老+社区养老模式，减少对机构养老的依赖有很大关系。在养老“9073”的模式下（90%居家、7%社区、3%机构），部分养老需求转向居家养老或社区服务。此外，智慧养老的兴起，使智能监测、远程医疗等技术惠及老年人生活，让老人更倾向于居家接受服务，而非入住机构。此外，政府提高养老机构准入门槛，淘汰不符合标准的机构，导致数量减少但质量提升。

2018-2025年中国注册登记养老机构数量及增速



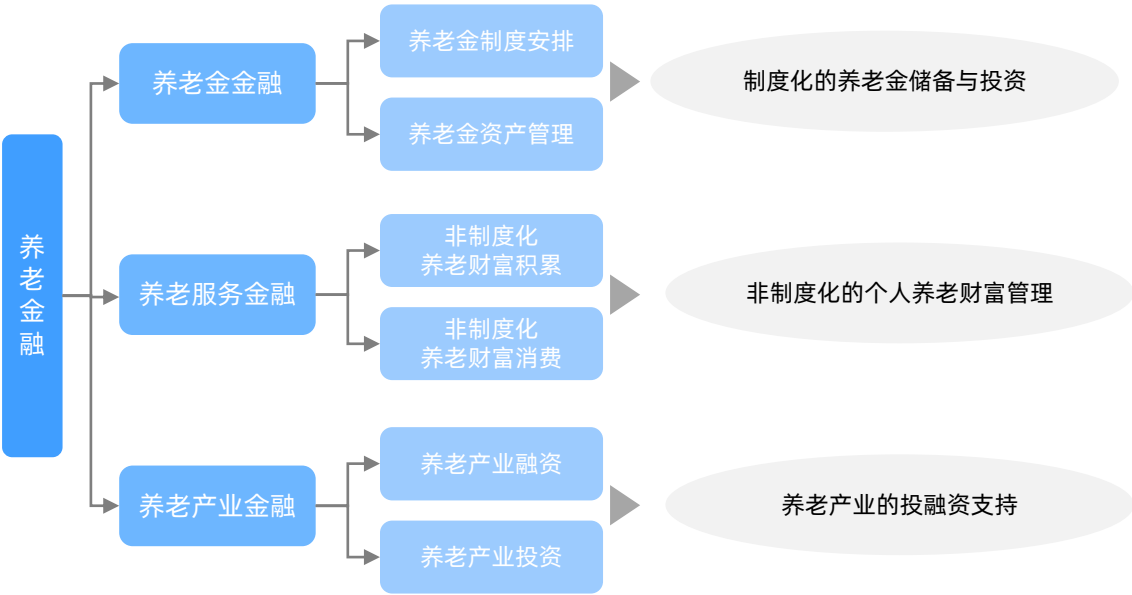
2018-2025年中国养老服务床位数量及增速



银发经济养老金融：注重资金的长期积累和稳健增值

◆ 养老金融是为应对人口老龄化及满足老年人养老需求而展开的全部金融活动，主要包括养老金、养老服务、养老产业三大领域。养老金融具有长期性、稳健性、安全性等特点，注重资金的长期积累和稳健增值。

养老金融概念框架



◆ 养老金融的重要性如今愈发突出，成为社会各界关注的焦点。商业银行作为实现养老金融的关键力量，紧跟政策导向，积极布局养老金融相关业务，并将其上升到公司战略层面。在推进养老金融的进程中，国有大行勇当“头雁”，不断创新养老金融服务模式，深度涉足养老产业。区域银行则凭借当地特色和资源优势，开展多样化的养老金融实践。它们共同发力，助力构建多层次、多支柱的养老保险体系，通过多项贴心举措提升适老化金融服务水平，为老年人提供更优质、更便捷的金融服务，全力推动养老金融迈向高质量发展新高度。

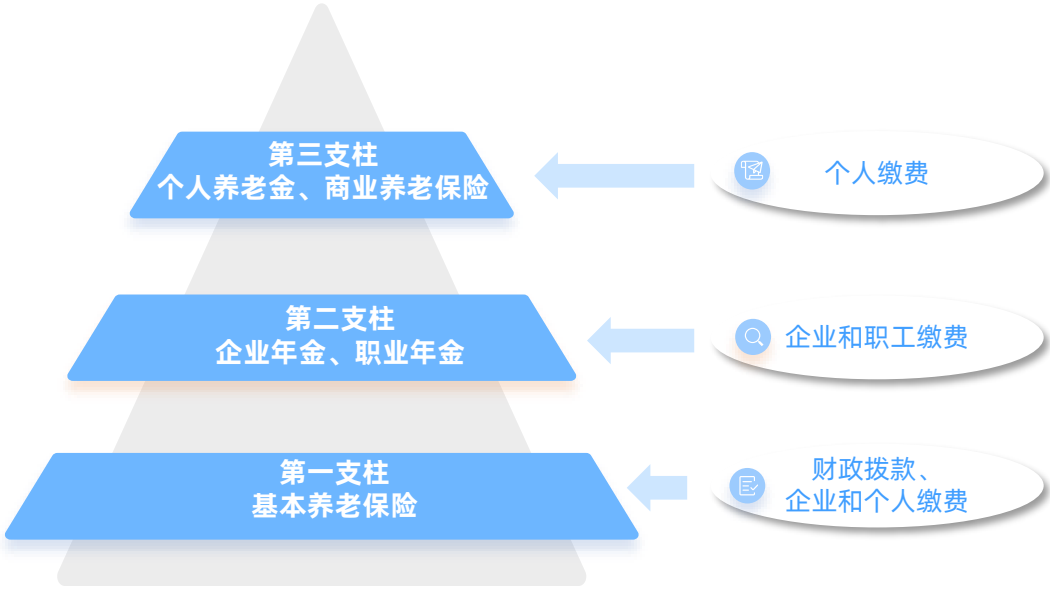
四大行养老金融战略方向

银行	养老金融战略
 中国银行 中国银行	积极创新“候鸟养老”客户服务模式，大力推进网点及线上渠道的适老化改造，全力打通养老金融服务的“最后一公里”。紧扣人口老龄化国家战略，从养老金金融、养老个人金融等四方面发力，深化金融供给侧结构性改革，精准对接并满足民众不断增长的多样化养老需求。
 中国农业银行 农业银行	积极响应人口老龄化国家战略，全力助推多层次、多支柱养老保险体系构建。不断丰富养老金融产品矩阵，从基金、理财到保险，提供多元选择。持续优化客户服务体验，以贴心服务提升满意度。积极发展养老金融，大力推广个人养老金服务，精准对接客户差异化养老规划需求，以高质量金融服务护航居民高品质养老生活。
 中国工商银行 工商银行	深入贯彻中央金融工作会议精神，精心完善养老金融工作布局。持续优化养老金融产品和服务，创新综合化、生态化服务模式，围绕政府、企业、个人三端定制金融方案。充分发挥总行与分行养老金融委员会统筹作用，强化全集团跨专业、跨层级、跨客群协同，构建统一规划、分类管理的高效工作格局，助力养老金融发展。
 中国建设银行 建设银行	前瞻布局养老金融蓝海，发布统一品牌“健养安”，推进“1314”养老金融服务体系。通过打造智能化养老金融服务平台，提升服务效率与质量，持续夯实养老金融基础，精准明晰养老产业金融定位。同时，聚焦客户需求，不断强化养老金融客户服务能力，为养老金融发展注入强劲动力。

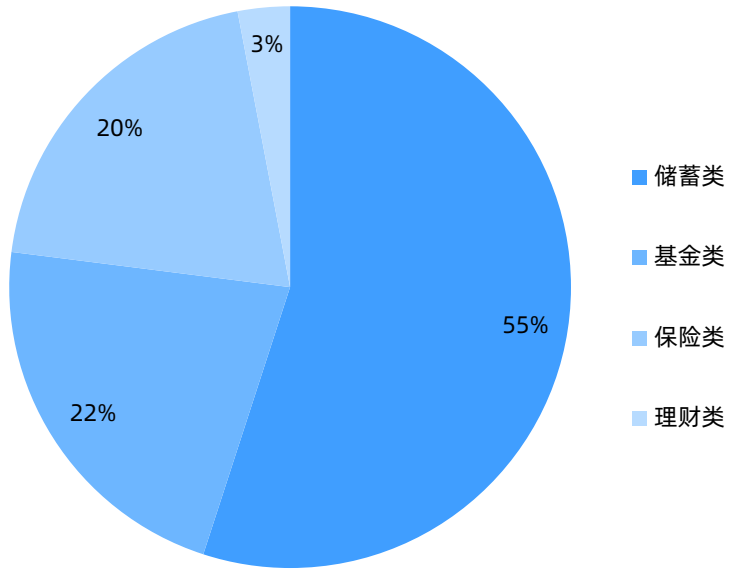
银发经济养老金融：养老金金融是养老金融体系的核心部分

- ◆ 养老金，也称退休金、退休费，是一种最主要的社会养老保险待遇。它是由国家有关文件规定的，在劳动者年老或丧失劳动能力后，根据其对社会所作的贡献和所具备的享受养老保险资格或退休条件，按月或一次性以货币形式支付的保险待遇。养老金金融是养老金融体系的核心组成部分。养老金金融是指通过制度安排和管理，为社会成员在老年时期提供经济保障的一系列金融活动。其本质是通过制度化的资金积累与市场化投资运营，实现养老资产的价值增值，从而保障老年人基本生活需求。
- ◆ 现阶段我国已初步建立了以基本养老保险为主的养老金三支柱体系。第一支柱为基本养老保险，由城镇职工基本养老保险和城乡居民基本养老保险构成，根据人社部数据，截至2024年末，我国基本养老保险参保人数约为10.7亿人，基本实现对劳动适龄人口的全覆盖。第二支柱为企业年金及职业年金，企业年金由企业及其职工自愿建立，职业年金由机关事业单位及其工作人员建立。根据人社部数据，截至2024年末，我国企业年金规模达3.6万亿元；职业年金基金投资运营规模为3.11万亿元。第三支柱为个人养老金，截至2024年末，我国个人养老金账户开立超过7300万户，但缴存人数少、人均缴存金额低，制度尚处于快速发展阶段。
- ◆ 国家社会保险公共服务平台数据显示，截至2024年12月17日，国内个人养老金产品目录以储蓄类产品为主，占比过半；保险类和基金类产品的数量合计超4成；而理财类产品的数量较少，产品供给以低风险低收益品种为主，收益率预期不高或在一定程度上突出了个人养老金的抵税功能而削弱了其资产增值属性。

养老金三支柱体系



个人养老金产品分类占比（截至2024年12月17日）



银发经济养老金融：养老服务金融助力老年财富管理与生活保障

行行查
HangHangCha

◆ 养老服务金融是金融机构围绕社会成员全生命周期的养老需求，提供的多样化、创新性金融产品与服务。其本质是通过市场化手段满足个人养老财富积累、消费及衍生需求，旨在补充制度化的养老金体系，提升老年生活品质。

养老服务金融的主要功能



按服务目标养老服务金融可分为两大类

类别	细分	描述
养老财富管理	储蓄类	养老专项存款、个人养老金账户等低风险产品
	投资类	养老目标基金、养老信托计划、商业养老保险（如年金保险、增额终身寿险）
	规划类	养老财务顾问服务、遗产规划、税务优化方案
养老消费支持	支付工具	住房反向抵押贷款（以房养老）、养老消费分期产品
	风险保障	长期护理保险、失能收入保险、老年意外险
	场景服务	适老化支付终端改造、老年专属银行卡的非现金支付功能

养老服务金融产品体系丰富

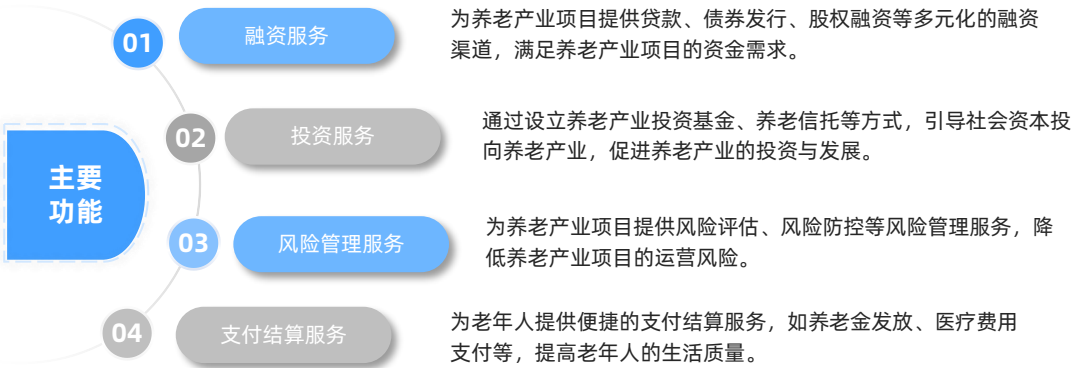
类别	代表产品	特点
养老储蓄类	特定养老储蓄(长期限、利率较高)、养老储蓄账户	低风险、稳健收益，适合保守型投资者
养老保险类	商业养老保险（传统型、分红型）、长期护理保险、住房反向抵押养老保险	兼具保障与财富增值功能，部分产品可对冲长寿风险
养老投资类	养老目标基金（目标日期/风险型）、养老理财（固收+权益配置）、养老信托	风险收益分层，满足不同风险偏好
房产相关类	反向抵押贷款、房产置换养老、养老社区产权模式	盘活房产资产，解决现金流短缺问题
综合服务类	一站式养老财务规划、适老化金融科技（如语音助手、大字体界面）	提升服务便捷性，降低老年人使用门槛

银发经济养老金融：养老产业金融是银发经济发展的资本引擎



◆ 养老产业金融是指通过金融工具为养老相关产业提供投融资支持的金融活动，其目的是满足养老产业的投资需求，支持养老产业的发展。养老产业金融涵盖了融资和投资两方面，服务对象为养老产业，包括养老服务、养老用品、养老服务业等，旨在通过金融手段促进养老产业的可持续发展。

养老产业金融的主要服务内容



养老产业金融主要支持领域

细分领域	具体内容
养老服务业	生活照料、康复护理、心理支持、智慧养老平台建设（如健康监测系统开发）
养老产品制造业	老年辅助器具（如助行器）、适老化电子产品、老年专用药品研发与生产
养老支持体系	养老金融产品设计（如反向抵押贷款）、养老服务人员培训、养老设施智能化改造

养老产业金融主要资金来源

类别	细分	描述
市场化融资	债权融资	养老产业专项债券、应收账款质押贷款
	股权融资	养老产业引导基金、私募股权投资基金
	资产证券化	养老社区收益权ABS、护理服务收费权证券化
政策性支持	专项再贷款	央行设立普惠养老专项再贷款，定向支持中小养老机构
	财政贴息	地方政府对养老产业贷款给予50%利息补贴
	PPP模式	政府与社会资本合作建设养老基础设施，如上海“长者照护之家”项目

养老产业金融面临的挑战

养老产业自身特点导致融资难度大

养老产业具有资金需求量大、回收周期长、风险较高等特点，一定程度上造成了金融资本对养老产业的排斥情绪。部分养老机构经营管理水平有限，收益面临较大的不确定性，也使得金融机构在为其授信时较为谨慎。

金融支持总量不足

尽管养老产业贷款增速迅猛，但目前金融对养老产业支持的总量依然不足。我国养老金融前期发展更偏重养老金融和养老服务金融两方面，养老产业金融发展相对滞后，金融在支持养老产业发展中的作用不够明显。

银发经济医疗保健：老龄化趋势下，医药保健市场增长潜力巨大



- ◆ 老年医疗保健是以维护和促进老年人健康为核心，通过整合医疗、护理、康复、预防等服务，实现疾病防控、功能维持及生命质量提升的综合性体系。人口老龄化加速，有望成为中国未来10-20年最大的基本面之一，这将带来庞大的医疗需求。
- ◆ 市场上保健食品种类繁多，针对老年人的保健食品主要集中在增强免疫力、改善睡眠、辅助降血糖、降血脂、抗氧化等多个方面。
- ◆ 此外，中国医药行业与医疗器械行业市场规模的扩张与银发经济密切相关，人口老龄化、政策驱动和技术创新共同推动两者协同发展，形成巨大的市场增量空间。根据知原药业招股说明书数据，预计2025年中国医药市场规模将超过1.8万亿人民币，而据阿为特招股说明书数据，预计2025年中国医疗器械市场规模将超过1.2万亿人民币。

我国保健品行业代表性企业

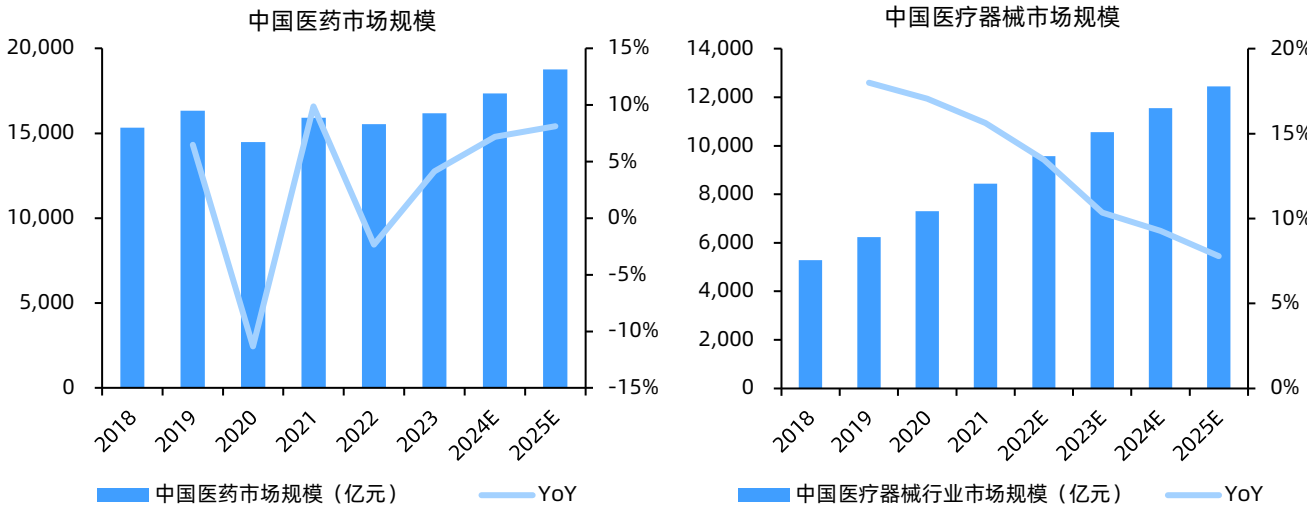


● 老龄化带来的健康需求为保健品行业提供了广阔的发展空间。我国保健品企业竞争激烈且格局多元，国际品牌、传统中药企业与新兴势力各有优势，行业呈现品牌化、科技化、细分化发展趋势。

老龄化常见疾病



2018-2025年中国医疗器械与药品行业市场规模及增速



银发经济医疗保健：人均医保支出攀升，大健康成为市场发力点

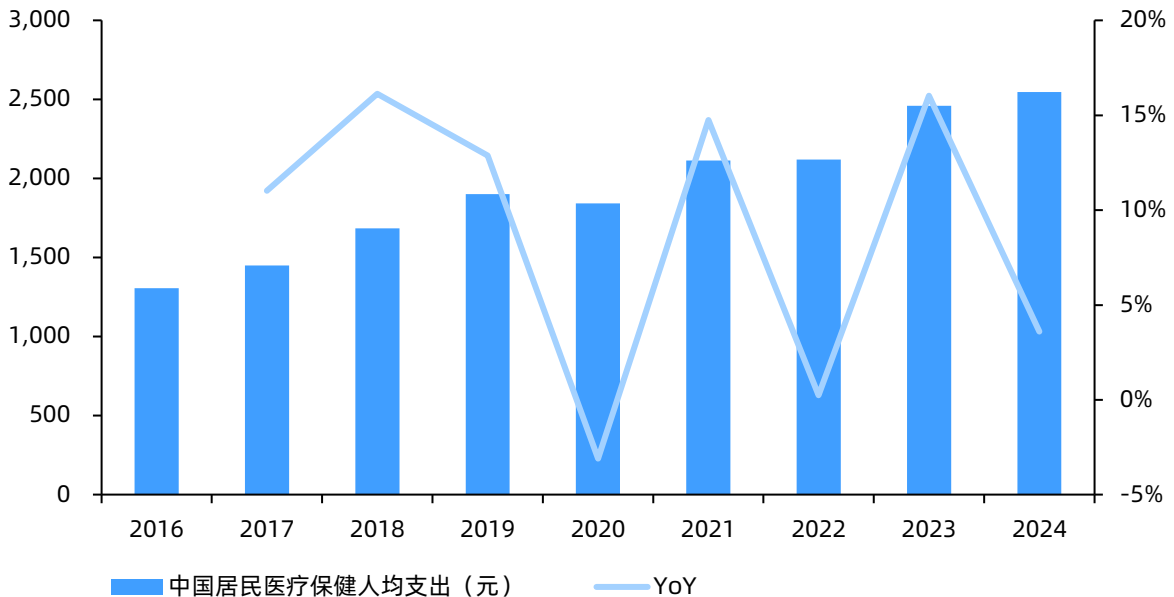


◆ 人口老龄化加速，有望成为中国未来10-20年最大的基本面之一。当前我国65岁以上老龄人口急剧增长，2024年，我国65岁及以上人口约2.2亿人，占总人口的15.6%。预计到2030年，我国65岁及以上人口将显著增长至2.8 亿人，占比将提升至20%，将带来庞大的医疗需求。根据国家统计局发布《中华人民共和国2024年国民经济和社会发展统计公报》，2024年全国居民人均医疗保健支出为2547元，相比上年增长了3.6%，占人均消费支出的比重为9.0%。

老年人医疗保健主要涵盖内容

预防保健	包括疾病预防、健康咨询、健康状态辨识、健康危险因素干预等。
健康管理	如家庭医生签约服务、老年人档案管理、健康随访等。
疾病诊疗	针对老年人常见慢性病（如糖尿病、心脏病）及急性疾病的诊断、治疗和康复服务。
康复护理	提供身体、心理和社会功能恢复的康复服务，如肢体训练、认知功能康复等。
长期护理	包括居家护理、社区护理和机构护理，为需要长期照护的老年人提供综合性护理服务。
心理支持和 社会支持	关注老年人的情感福祉，提供心理咨询和社会参与机会。
健康促进	通过健康教育、生活方式指导等方式提升老年人的生活质量。

2016-2024年中国居民医疗保健人均支出



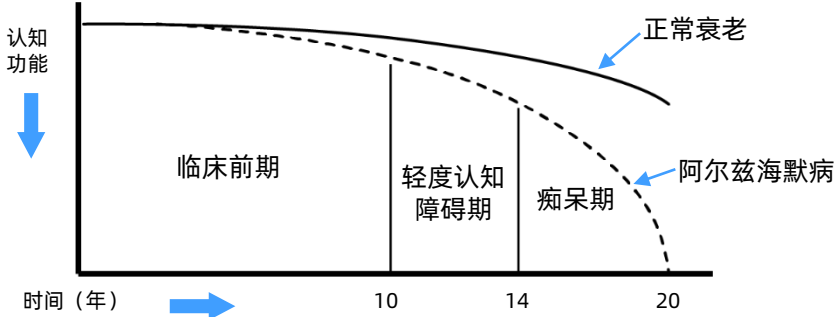
- ◆ 居民医疗保健支出占比持续上升，银发经济在医疗健康领域展现出多维度的发展机遇。
- **在医药方面：**重点聚焦于老年病的早期筛查技术（如基因检测、分子诊断）以及创新药物的研发（针对心血管、糖尿病、神经退行性疾病等），同时需注重药物耐受性的优化及适老化剂型的设计，以满足老年患者的特殊需求。
- **在器械方面：**康复设备市场需求旺盛，智能监测设备（如血压计、血糖仪）正加速普及，企业正积极向“产品+服务”的综合模式转型，以更好地服务于银发健康市场。

银发经济医疗保健：阿尔兹海默症是常见的神经退行性疾病



◆ 老年痴呆包括阿尔茨海默症和血管性痴呆。其中，阿尔茨海默症是一种进行性、不可逆转的神经退行性疾病，根据世界卫生组织（WHO）及国际阿尔茨海默病协会（ADI）的数据，阿尔茨海默症患者占痴呆患者总数的60%至80%；血管性痴呆是老年性痴呆的先兆，是脑血管疾病导致脑功能下降的结果。由上海交通大学医学院附属仁济医院牵头编撰的《中国阿尔茨海默病报告2024》显示，我国现存的阿尔茨海默症及其他痴呆患病人数将近1,700万例。

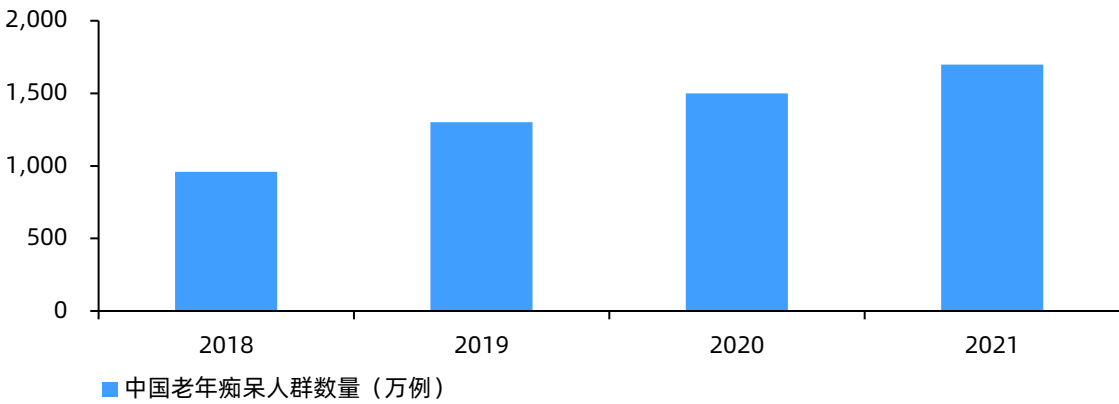
阿尔兹海默病整体病程大约为20年



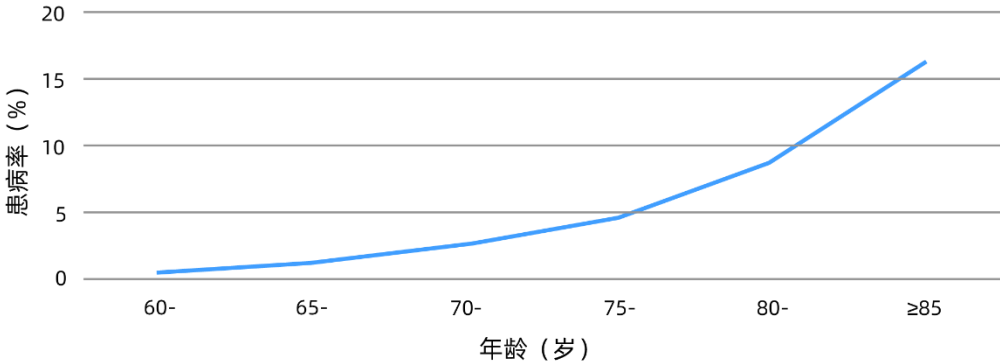
老年痴呆分类及临床特征

临床特征	老年痴呆	
	阿尔兹海默病 (AD) (病例占比60%-80%)	血管性痴呆 (VD) (病例占比20%-40%)
发病年龄	多在60岁以后	多在50~60岁
发病形式及经过	发病极缓慢，为潜隐性	可有急性发病，病程呈波动性，阶梯性恶化
精神症状	记忆力下降及智力缺损	多为情绪脆弱，情绪不稳定或情绪低落
神经系统局限症状及体征	晚期出现肌萎缩、肌阵挛	可伴发偏瘫、帕金森症状群、步行障碍、假性球麻痹等
CT	弥漫性脑皮质萎缩	多发梗塞、腔隙和软化灶
全身性疾病	无	多数合并高血压、糖尿病、高脂血症等
缺血指数评分表(HIs)	<4分	>7分

我国阿尔兹海默症及其他痴呆患病人数约1700万例



中国不同年龄组老年人阿尔兹海默病及其它痴呆患病率

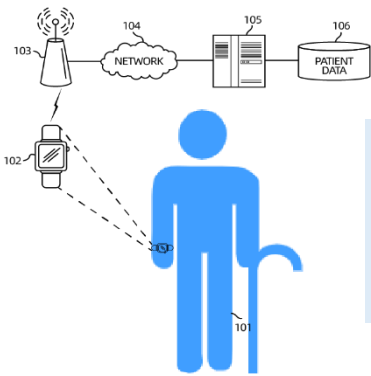


银发经济医疗保健：帕金森病是慢性进行性神经系统退行性疾病



- ◆ 帕金森病（Parkinson's Disease, PD）是一种慢性、进行性的中枢神经系统变性疾病，其核心病理特征在于黑质多巴胺能神经元的显著退化和缺失，以及黑质纹状体多巴胺能通路的明显退化。这种神经元的损伤致使纹状体中多巴胺水平下降，进而引发一系列复杂的运动和非运动症状。作为仅次于阿尔茨海默病的第二大神经退行性疾病，帕金森病对患者的日常生活造成了严重影响。
- ◆ 目前，传统药物和手术治疗仅能缓解其症状，无法阻止疾病进展。因此，深入探究帕金森病的致病机理，并开展针对性治疗，已成为全球科研领域的热点和战略高地。

苹果专利可以监测帕金森氏疾病



该专利主要基于Apple Watch中的运动传感器和其他生物传感器。这些传感器能够连续监测用户的运动状态、震颤情况以及其他与帕金森氏疾病相关的生理指标。

帕金森病的主要症状

运动症状

静止性震颤：约70%患者以单侧手指“搓丸样”或“压片滚动”震颤为首发症状，情绪激动时加重，活动时减轻或消失。

运动迟缓：动作启动困难（如写字时出现“小写症”）、面部表情减少及步态异常。

肌强直：伸肌与屈肌张力同时增高，被动运动时呈“齿轮样”或“铅管样”阻力。

姿势不稳：晚期患者易跌倒，表现为前倾或后倾姿势，平衡反射减弱

非运动症状

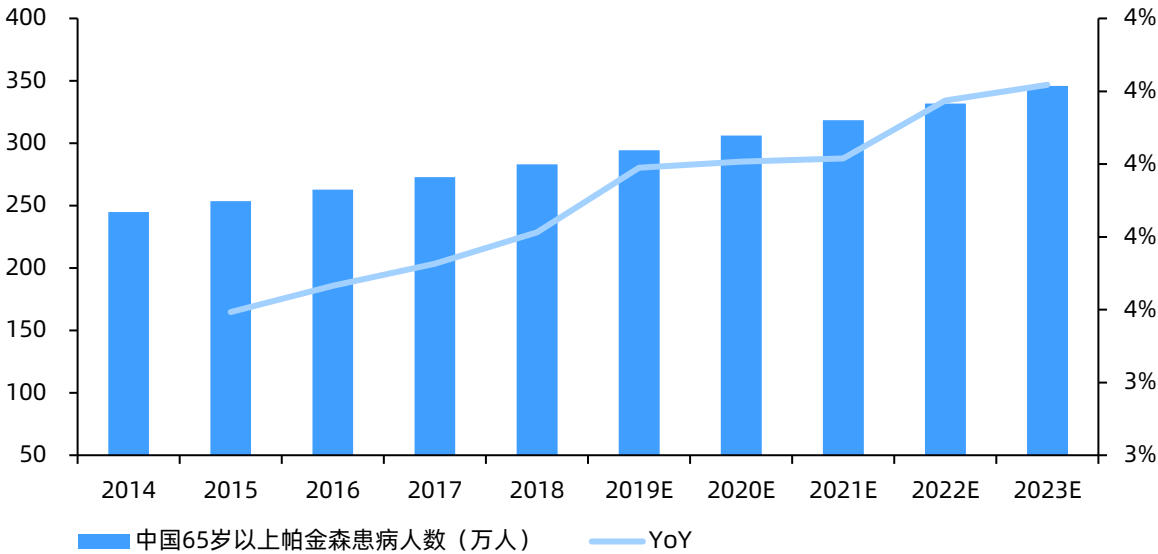
嗅觉减退：早期较为常见，可能早于运动症状出现。

自主神经功能障碍：包括便秘、多汗、排尿困难等。

精神症状：抑郁、焦虑、认知障碍及快速眼动睡眠行为异常（RBD）。

其他：疼痛、疲劳及视觉障碍（如眼球运动异常）。

2020-2025年中国65岁以上帕金森患病人数及增速



银发经济医疗保健：我国老年人高血压患病形势不容乐观

◆ 随着老年人口比例的不断上升，由于老年人身体机能逐渐衰退，血管弹性减弱，加之多年生活习惯和可能存在的慢性疾病影响，高血压的发病率在老年人群中显著较高。这一趋势不仅增加了医疗系统的负担，也对老年人的生活质量构成了严重威胁。因此，加强老年人健康管理，提高高血压的预防和控制意识，成为应对人口老龄化挑战、保障老年人健康的重要举措。

常见抗高血压药物机理及特征

类型	作用机制	代表药物	适用范围
利尿剂	主要通过利钠排尿、降低容量负荷而发挥降压作用	呋塞米、氢氯噻嗪	尤其适用于老年高血压、单纯收缩期高血压或伴心力衰竭患者，也是难治高血压的基础药物之一
β-受体阻滞剂	主要通过抑制过度激活的交感神经活性、抑制心肌收缩力、减慢心率发挥降压作用	普萘洛尔、美托洛尔、比索洛尔	尤其适用于伴快速性心律失常、冠心病慢性心力衰竭、交感神经活性增高以及高动力状态的高血压患者
钙离子通道阻滞剂 (CCB)	主要通过阻断血管平滑肌细胞上的钙离子通道发挥扩张血管降低血压的作用	氨氯地平、硝苯地平	适用范围相对广，尤其适用于老年高血压、单纯收缩期高血压、伴稳定性心绞痛、冠状动脉或颈动脉粥样硬化及周围血管病患者
血管紧张素转化酶抑制剂 (ACEI)	抑制血管紧张素转化酶，阻断肾素血管紧张素II的生成，抑制激肽酶的降解而发挥降压作用	卡托普利、依那普利、贝那普利	具有良好的靶器官保护和心血管终点事件预防作用，尤其适用于伴慢性心力衰竭、心肌梗死后心功能不全、心房颤动预防、糖尿病肾病、非糖尿病肾病、代谢综合征、蛋白尿或微量白蛋白尿患者
血管紧张素II受体拮抗剂 (ARB)	具有较强的特异性，通过作用于特定受体从而阻断血管紧张素II与其受体结合，实现舒张血管而达到降压目的	氯沙坦、缬沙坦、厄贝沙坦	尤其适用于伴左心室肥厚、心力衰竭、糖尿病肾病、冠心病、代谢综合征、微量白蛋白尿或蛋白尿患者以及不能耐受ACEI的患者，并可预防心房颤动

我国高血压的分类

高血压分级	标准
1级高血压（轻度）	收缩压在140-159mmHg之间，舒张压在90-99mmHg之间
2级高血压（中度）	收缩压在160-179mmHg之间，舒张压在100-109mmHg之间
3级高血压（重度）	收缩压≥180mmHg，舒张压≥110mmHg

高血压的三种治疗方式



改变生活方式

减少钠盐摄入，增加钾摄入
合理膳食，平衡膳食，控制体重
不吸烟，彻底戒烟，避免被动吸烟
不饮或限制饮酒增加运动
减轻精神压力，保持心理平衡



药物治疗

常用的五大类降压药物：CCB、ACEI、ARB、利尿剂和β受体阻滞剂
一般患者采用常规剂量，优先使用长效降压药物
高危患者或单药治疗未达标的高血压患者应进行联合降压治疗



微创介入疗法

高血压的微创介入治疗也叫肾动脉射频消融术(RDN)
对于未被控制，药物依从性不佳，有靶器官损伤，以及药物不耐受的高血压病人，RDN技术是一种新型的选择

银发经济医疗保健：糖尿病患者数量庞大，用药市场空间广阔



◆糖尿病是一种因胰腺分泌功能缺陷或胰岛素作用障碍而引发的代谢性疾病，其主要特征为血糖水平升高。该病的典型症状表现为“三多一少”，即多饮、多尿、多食以及体重减轻。若糖尿病患者的血糖长期得不到有效控制，将会对器官组织造成损害，并可能伴发眼、心、血管、肾、神经等多个器官的损害或功能不全，甚至衰竭，严重时可能导致患者残疾或死亡。根据世界卫生组织（WHO）及国际糖尿病联盟（IDF）专家组分类建议，糖尿病可分为I型、II型、妊娠糖尿病以及其他特殊类型共4种。

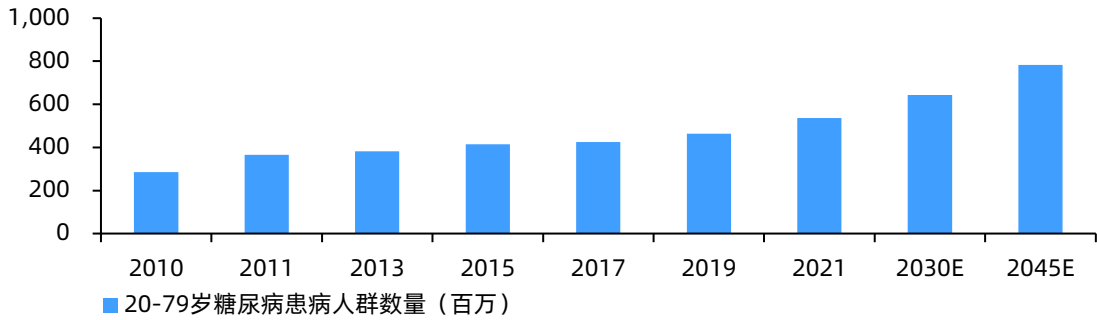
糖尿病分类及特征

类型	特征
I型糖尿病	又被称为胰岛素依赖型糖尿病，由于胰岛β细胞被破坏，因而胰岛素分泌缺乏，需要终身依赖外源性胰岛素补充以维持生命。
II型糖尿病	又被称为非胰岛素依赖型糖尿病，以胰岛素抵抗为主伴胰岛素不足；或以胰岛素分泌不足为主伴胰岛素抵抗。
妊娠糖尿病	在妊娠期间首次发现的糖耐量受损或糖尿病称为妊娠糖尿病。
其他特殊类型糖尿病	胰腺疾病或内分泌疾病引起的糖尿病、药物引起的糖尿病以及遗传疾病伴有的糖尿病等，某些类型的糖尿病是可以随着原发疾病的治愈而缓解的。

糖尿病用药分类

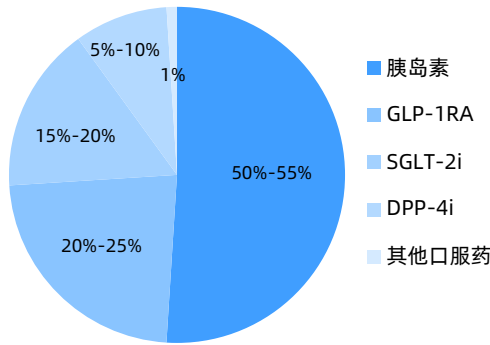
给药方式	种类	代表药物
注射给药	胰岛素	门冬胰岛素
	GLP-1受体激动剂	利拉鲁肽
	双胍类	二甲双胍
口服给药	磺脲类	格列本脲、格列齐特
	格列奈类	瑞格列奈、那格列奈
	α-糖苷酶抑制剂	阿卡波糖、伏格列波糖
	噻唑烷二酮类	罗格列酮、吡格列酮
	二肽基肽酶-4(DPP-4)抑制剂	西格列汀、沙格列汀
	钠-葡萄糖协同转运蛋白2(SGLT2)抑制剂	达格列净、恩格列净

全球20-79岁糖尿病患者数量增长趋势

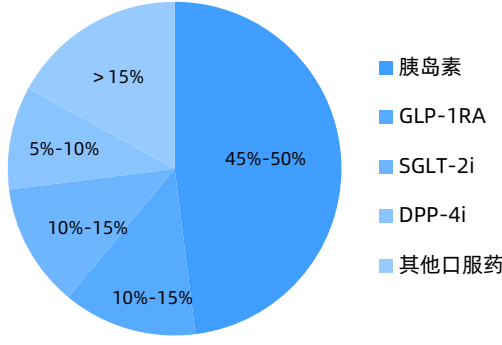


◆从全球来看，胰岛素占据糖尿病用药市场的最大份额，其次是GLP-1，其次是新型的口服用药。从我国来看，胰岛素也占据糖尿病用药市场的最大份额，之后是GLP-1受体激动剂、SGLT-2抑制剂、DPP-4抑制剂三大类新型药物。

2024年全球糖尿病用药格局



2024年中国糖尿病用药格局



银发经济医疗保健：养老机器人将在智慧养老领域发挥重要作用

行行查
HangHangCha

◆ 养老机器人覆盖了老年人的生理、安全和精神三个需求层次，且在生活辅助、健康监护、情感陪伴等多数场景下均有机器人产品，按照用途，养老机器人可分为康复机器人、护理机器人和陪伴机器人三类。从养老阶段来看，健康和自理阶段的老人对陪伴机器人的需求较多，半自理和失能老人的需求主要为康复和护理机器人。

不同类型养老机器人对比

对比	康复机器人	护理机器人	陪伴机器人
图例			
起步时间	20世纪60年代	20世纪80年代	20世纪90年代
特点	帮助老年人进行康复训练，如行走、下肢功能训练等，适用于脑卒中或脊髓损伤患者。	辅助完成日常生活活动，如穿衣、吃饭、上下床等，特别适合失能、失智老人。	提供情感交流与娱乐，如唱歌、跳舞、聊天等，满足老年人的情感需求。
代表性企业	大艾机器人、傅利叶智能、程天科技、安杰莱科技、迈步机器人、奇诺动力等。	新松机器人、戴恩医疗、和康生物、益康生活、伊利诺、麦迪科技等。	康力优蓝、Gowild公子小白、CANBOT爱乐优、礼宾医疗等。

养老机器人主要应用场景

家庭照护	养老院与社区照护	智慧养老综合体
养老机器人可以为独居或行动不便的老人提供全方位的照护服务，减轻家庭成员的照顾负担。	在养老院或社区里，机器人能协助护理人员进行日常巡查、紧急救助和环境监测等，提高照护效率。	未来，养老机器人还将与智能家居、远程医疗等技术深度融合，构建一个全方位的智慧养老生态圈。

养老机器人市场发展趋势

技术融合与创新	> 随着AI、物联网、柔性机器人等技术的不断发展，养老机器人将更加智能化、人性化，能够更好地满足老年人的多样化需求。
成本降低与普及化	> 通过规模化生产和政府补贴等措施，养老机器人的成本将逐渐降低，未来有望普及到更多普通家庭。
个性化与适老化设计	> 养老机器人将更加注重个性化定制和适老化设计，根据老人的身体状态和生活习惯，提供定制化的照护服务。
人机协作融合	> 养老机器人将与医护人员、养老服务人员等紧密协作，形成更高效的养老服务体系，共同为老年人提供优质的养老服务。

银发经济老年用品：消费趋向多元化、高品质和健康化

- ◆ 老年用品是指为老年人设计和生产的产品，旨在满足其日常生活、健康护理、休闲娱乐等方面的需求。这些产品通常针对老年人因身体功能退化、疾病或其他特殊生理心理特点而产生的特殊需求。老年用品的分类多样，涵盖了从日常生活到健康管理、从科技智能到传统辅助的广泛领域，旨在全面提升老年人的生活质量。
- ◆ 2019年底，我国工信部、民政部等五部门印发《关于促进老年用品产业发展的指导意见》，明确到2025年，老年用品产业总体规模超过5万亿元。根据工信部数据，截至2023年，我国养老用品市场规模已达约5万亿元，未来仍有广阔发展空间。

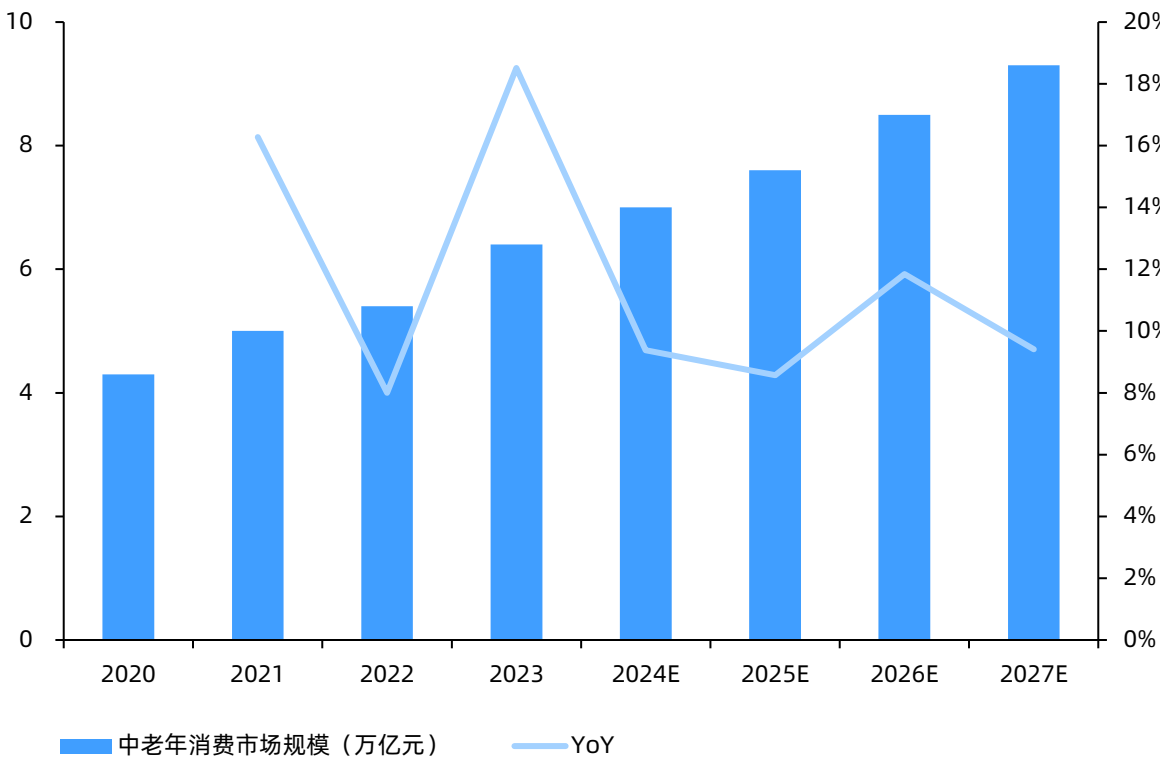
老年用品主要分类

健康护理类	生活便利类	休闲娱乐类	营养保健类
✓ 医疗器械：血压计、血糖仪等 ✓ 康复辅具：轮椅、拐杖等 ✓ 健康监测设备：智能手环、智能手表等	✓ 家居用品：防滑地板、扶手等 ✓ 个人护理用品：老年专用护肤品、便携式坐便器等 ✓ 智能穿戴设备：紧急呼叫器、定位手环等	✓ 健身器材：跑步机、椭圆机等 ✓ 文化娱乐用品：学习用品、棋牌等 ✓ 旅游休闲用品：折叠椅、遮阳伞等	✓ 保健食品：钙片、维生素等 ✓ 滋补品：人参、枸杞、燕窝等 ✓ 特殊医学用途配方食品：如低糖、低脂、高纤维等

老年用品市场的发展趋势

➢ 随着科技发展，老年用品将更加注重新智能化。例如，智能拐杖可以监测老年人的步数、心率等健康数据，并具备紧急呼叫功能。	➢ 老年用品的设计将更加注重老年人的使用体验。例如，家具的边角将采用圆滑设计，防止磕碰；产品的操作界面将简化，便于老年人理解和操作。	➢ 老年用品行业将与其他行业进行跨界融合，如“医养结合”模式，将医疗服务与养老服务相结合，为老年人提供全方位的照护。
智能化升级	适老化设计	跨界融合

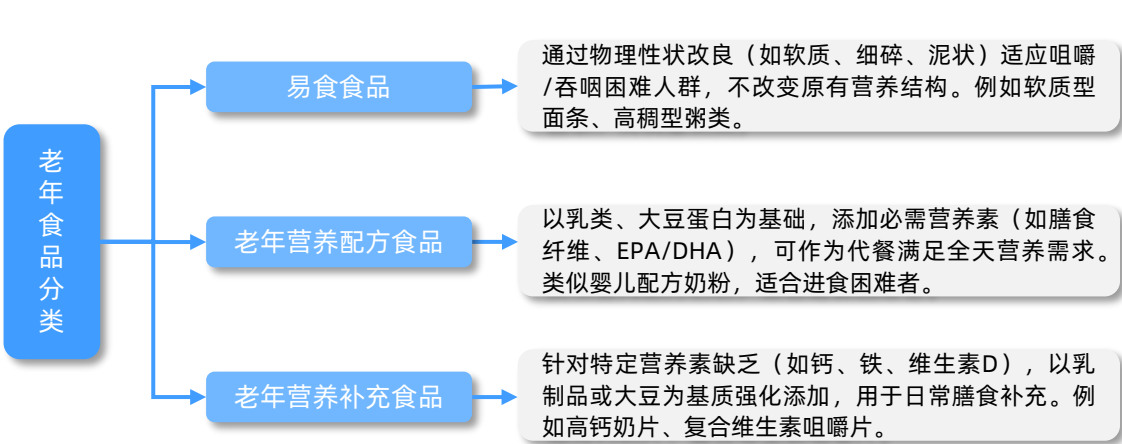
2020-2027年中国中老年消费市场规模及增速



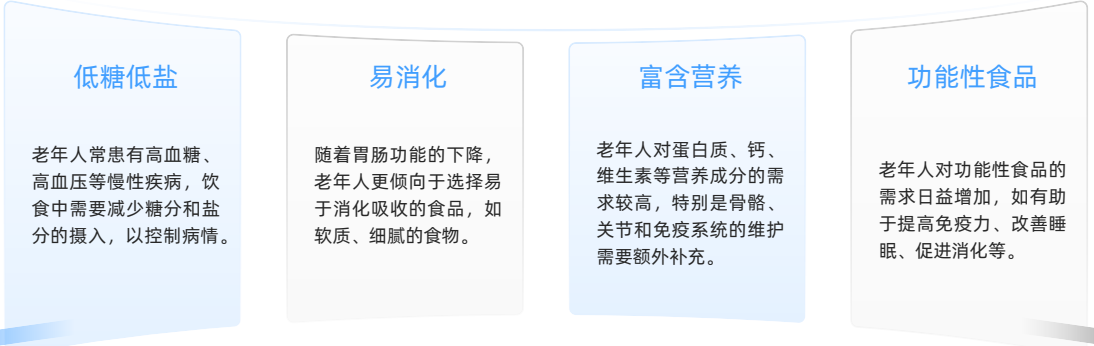
银发经济老年用品：老年食品是银发经济的重要组成部分

◆ 老年食品是专为适应老年人生理特点设计的特殊膳食食品，通过改善食物物理性状和调整营养成分，解决咀嚼/吞咽功能下降、营养不良等问题。根据《食品安全国家标准 老年食品通则》（征求意见稿），其核心是满足老年人饮食需求与营养均衡。

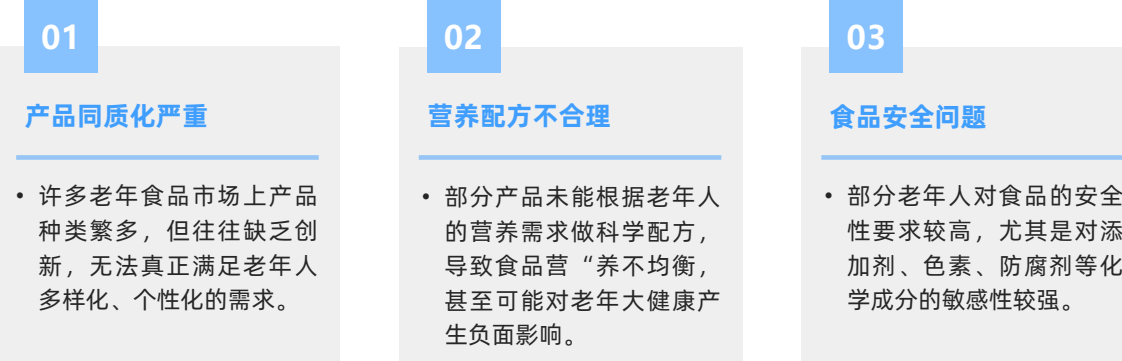
老年食品分为三大类



老年群体的食品需求特点



老年食品市场的痛点



老年食品代表性企业



银发经济养老地产：入局者众多，运营模式和盈利方式多样



- ◆ 养老房地产业中，以养老机构为主的养老设施投资、开发等对资本占用较多，属于重资产运营模式。近年来因政策支持、人口老龄化加深及老年人消费水平提高而发展潜力巨大，吸引了房地产公司、保险公司等多元社会资本参与，各类养老机构在机构性质、营利性要求、服务形式和水平、服务收费等方面存在较大差异。
- ◆ 目前主要包括四类参与者：房地产公司、保险公司、专业养老服务运营公司、外企和实业公司等其他投资者。其中，房地产公司和保险公司是民营养老机构两大主力，前者擅长养老公寓开发，后者资金雄厚、可长期投资并与保险产品衔接。

社会办养老机构不同参与者的优劣势比较

投资方	代表公司	优势	劣势
保险公司	泰康、国寿、太保、平安等	- 资金规模较大，具备长期性和稳定性 - 人身险客户养老需求较高，养老社区具备客源 - 险企是养老社区医养服务的核心支付方，能够实现CCRC养老社区的产业链闭环	土地资源较弱，开发成本较高；养老服务供给和设施运营经验待丰富
房地产公司	万科、保利、远洋、越秀等	资金体量较大，土地资源相对丰富；开发经验充足，开发边际成本较低	资金周转要求高，养老社区后期运营面临挑战
养老服务运营公司	复星康养、亲和源、乐成养老等	具备护工、护士等专业养老服务人才资源，养老服务供给充足、养老设施运营经验丰富	初创企业居多、以区域性龙头为主，资金实力有限，重资产运营挑战大
其他投资者	法国欧葆庭、日本美邸等	外资养老设施国际化运营经验丰富，以轻重资产结合的模式快速进入市场	外企自建养老社区数量有限；外企国际化经验面临本土化挑战

社会办养老机构运营模式分析

模式	形式	特点
重资产	独立开发模式	投资+拿地+开发+运营
	合作开发模式	与合作方共同出资，险企普遍委托房企工程建设
	股权投资模式	收购现有养老机构，或入股成熟公司
	私募基金模式	设立或参与私募养老基金
	REITs模式	设立 REITs 间接参与
轻资产	租赁物业	1) 优势：易于统一管理，保证养老项目整体服务质量；保险企业开发养老社区，多为增强高净值客户养老保险产品的增值服务，自主开发、运营更利于扩大养老健康生态圈的需求 2) 劣势：资金规模大、回报周期长
	第三方合作/委托管理	1) 优势：资金规模不大、回报周期较短 2) 劣势：稳定性存疑，可能影响服务质量
轻重结合	持有社区+第三方合作/租赁物业/委托管理	保留中高端自建养老机构的同时，较快扩大养老服务的地域和客群覆盖面

养老机构盈利模式分析

模式	分类	优劣势	代表案例
直接销售	独立产权：出售养老住宅产权或使用权，提供一定养老配置	快速回笼资金，但无法保证使用人群和交易用途，难以长期持续获得有品质的医养服务	早期房地产公司
	共有产权：出售住宅部分产权或使用权，持有物业获得长期收益	快速回笼资金，保证养老服务的持续性，赋予购买者资金权属，通过“基本服务费”避免购买者将养老房挪作他用；目前仍在试点，试点推广依赖政策支持力度	乐成养老“恭和家园”
对外出租	以押金快速回笼资金，结合月租费、护理费等获得长期收益	资金回笼慢，对养老服务供给和设施运营要求更高；但可以获得物业增值和长期稳定收益	泰康之家、太保家园等险企CCRC养老社区
租售结合	部分物业直接销售，部分物业对外出租	既可以快速回笼资金，又可以获得物业增值和长期稳定收益	万科“随园嘉树”

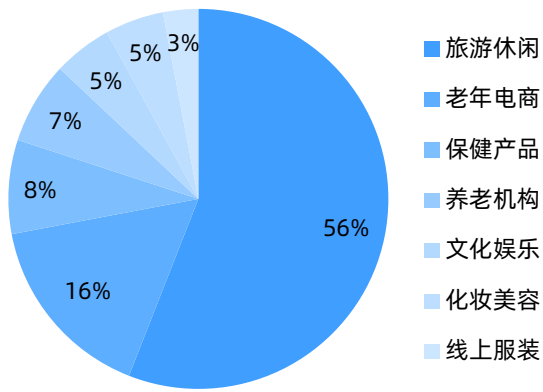
银发经济文化娱乐：老年群体的精神文化消费需求日益提升

- ◆ 中老年群体的需求除了日常消费、医养消费和保健消费外，其对于精神层面的需求也至关重要。运动健身、兴趣爱好培训以及旅游是中老年群体最喜欢的娱乐方式；近年来，中医健身功法、线上兴趣类课程以及游学的兴起极大地满足了中老年群体多元化娱乐需求。
- ◆ 老年教育是针对老年人群体的系统性教育活动，是终身教育体系的最终阶段，具有鲜明的社会公益属性。其核心目标是通过知识传授、技能培养和心理健康辅导，提升老年人的综合素质，实现个人发展与社会参与的双重价值。

银发经济的精神文化消费类型

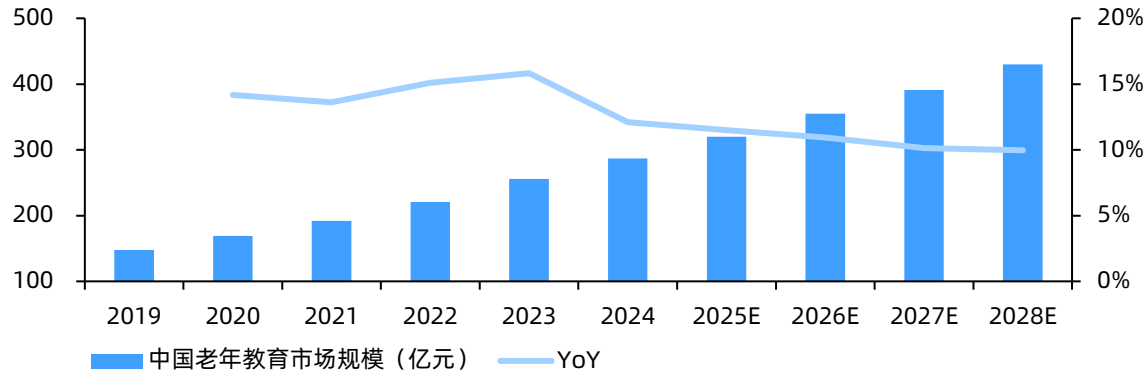


2023年中国老年群体可选消费结构



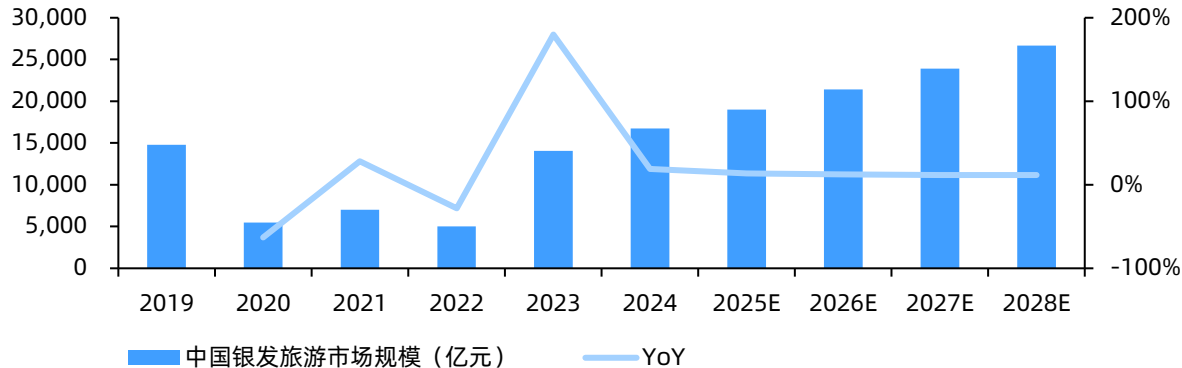
银发消费需求趋于多元化个性化，政策科技助力供给升级，AI+养老、银发文旅将成为重要支点。我国老年人需求结构已从生存型向发展型转变，呈现多元化、个性化的显著需求特征。从2023年中国老年群体可选消费结构来看，旅游休闲占比最高，达到50-60%。

2019-2028年中国老年教育市场规模及增速



- ◆ 近年来，我国银发旅游市场呈现出积极的增长态势。弗若斯特沙利文数据显示，2024年市场规模达约有1.6万亿人民币。随着我国人口老龄化的加速、国家政策的持续支持以及旅游产业结构的不断优化，预计到2028年，该市场规模将达到约2.7万亿人民币。

2019-2028年中国银发旅游市场规模及增速



银发经济政策法规：政策助力银发经济加速发展



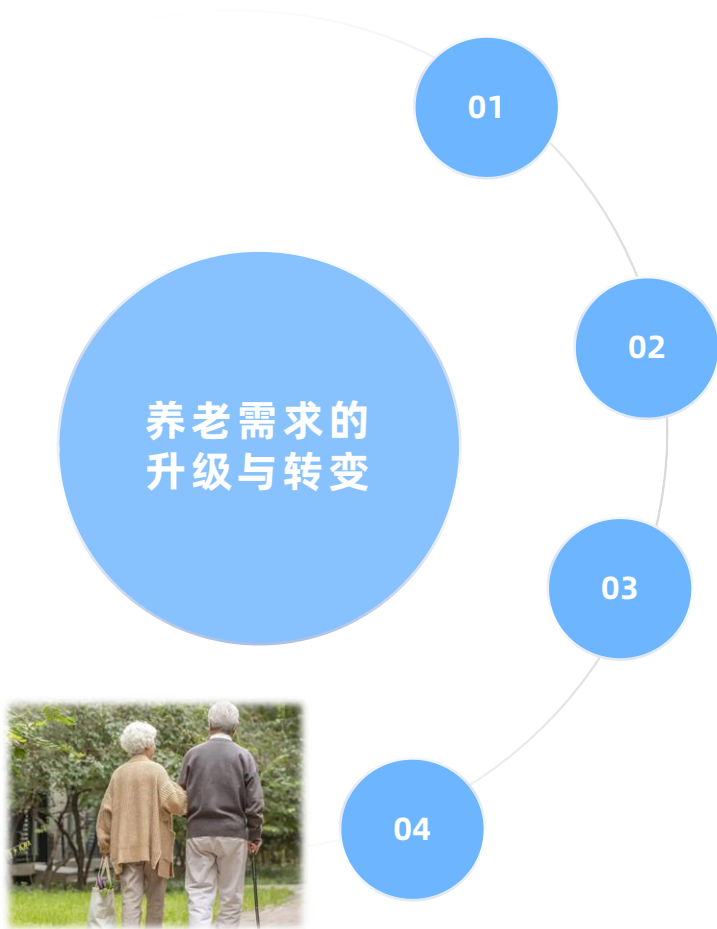
◆ 近年来，我国出台了一系列政策措施，旨在积极应对人口老龄化，推动银发经济高质量发展。这些政策不仅涵盖了养老服务、健康医疗、文化旅游等多个领域，还从人才培养、就业促进、自主创业等多方面给予支持，为银发经济的蓬勃发展提供了有力保障。随着政策的深入实施，银发经济正逐步成为推动经济社会发展的新引擎，为老年人提供更加优质、多元的服务，同时也为社会创造了更多的就业机会和经济价值。

银发经济相关行业政策

时间	政策名称	颁布单位	主要内容
2025年01月	《关于深化养老服务改革发展的意见》	中共中央、国务院	巩固居家养老基础作用，强化社区养老依托作用，优化机构养老专业支撑作用。推进养老机构分类改革。健全公办养老机构运营机制，鼓励社会力量新建或改扩建养老服务设施。加强残疾、失能和认知障碍老年人照护服务，着力增加护理型床位供给。
2024年05月	《关于银行业保险业做好金融“五篇大文章”的指导意见》	国家金融监督管理总局	第三支柱养老保险规范发展，养老金融产品更加丰富，对银发经济、健康和养老产业的金融支持力度持续加大，更好满足养老金融需求。
2024年01月	《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》	国务院	加快银发经济规模化、标准化、集群化、品牌化发展，培育高精尖产品和高品质服务模式，让老年人共享发展成果、安享幸福晚年，不断实现人民对美好生活的向往。
2023年05月	《关于推进基本养老服务体系建设意见》	中共中央办公厅、国务院办公厅	公办养老机构提供基本养老服务，强化对失能特困老年人的兜底保障。到2025年确保每个县（市/区/旗）至少有1所以失能特困人员专业照护为主的县级特困人员供养服务机构。光荣院可利用空余床位为其他老年优待抚恤对象提供优惠服务。鼓励机关和单位所属培训疗养机构转型为普惠型养老服务设施。
2023年02月	《关于推动非物质文化遗产与旅游深度融合发展的通知》	文化和旅游部	依托传统医药类非物质文化遗产发展康养旅游：丰富旅游产品-支持将非物质文化遗产与乡村旅游、红色旅游、冰雪旅游、康养旅游。
2021年12月	《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》	国务院	为养老服务多业态创新融合发展。实现围绕老年人衣食住行、康复护理的老年用品产业不断壮大，科技创新能力明显增强，智能化产品和服务惠及更多老年人的发展目标。
2021年11月	《关于加强新时代老龄工作的意见》	中共中央、国务院	（1）加强规划引导：编制规划，完善政策，推进老龄产业发展，鼓励地方发展特色老龄产业，统筹资金支持。（2）发展适老产业：制定老年用品服务目录和质量标准，推动相关行业规范发展，加大老年产品研发，发展养老新业态，鼓励开发健康保险产品，加强监管打击违法。
2021年03月	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》	国务院	发展银发经济，开发适老化技术和产品，培育智慧养老等新业态。
2020年12月	《关于建立健全养老服务综合监管制度，促进养老服务高质量发展的意见》	国务院办公厅	对防坠床和防跌倒等制定了标准，并实施养老机构的等级评定示范工程，在全国形成一批星级养老机构，通过示范带动行业质量整体提升。
2020年07月	《关于加快实施老年人居家适老化改造工程的指导意见》	民政部等9部门	2020年底前，采取政府补贴等方式，对纳入分散供养特困人员和建档立卡贫困人口范围的高龄、失能、残疾老年人家庭实施居家适老化改造，为决战决胜脱贫攻坚提供兜底保障。

银发经济观点分析：新时代老年人养老需求正发生转变

随着社会的快速发展和人口老龄化的加剧，养老需求正从生存型向发展型、享受型转变。如今，老年人不再仅仅满足于基本的衣食住行，而是更加注重生活的多元化、个性化和智能化。他们渴望参与社交活动，享受文化娱乐，追求健康养老，同时也对居家养老环境和社区养老服务提出了更高的要求。



从生存型向发展型、享受型转变

- ✓ **物质需求与精神需求并重：**老年人不再仅仅满足于基本的衣食住行需求，而是更加注重精神文化生活的丰富和品质的提升。他们渴望参与社交活动、文化娱乐、旅游休闲，以及获得继续学习的机会等，追求更加多元化、个性化的生活方式。
- ✓ **健康养老需求增加：**随着健康意识的提高，老年人对健康养老的需求日益增加。他们关注健康管理、疾病预防、康复护理等方面，希望获得更加专业、全面的健康服务。

对养老服务品质的要求提高

- ✓ **专业化、个性化服务需求：**老年人希望获得更加专业、个性化的养老服务，如定制化的健康管理方案、个性化的护理服务等。
- ✓ **智能化服务需求：**随着科技的发展，老年人对智能化养老服务的需求也在增加。他们希望利用智能设备、远程医疗等技术手段，实现更加便捷、高效的养老服务。

对居家养老环境的适老化改造需求增加

- ✓ **居家环境安全性：**老年人对居家环境的安全性要求更高，如防滑地板、无障碍设施等，以减少跌倒等意外事故的发生。
- ✓ **智能化家居设备：**老年人希望引入智能化家居设备，如智能手环、智能床垫等，以实时监测健康状况、提高生活便利性。

对社区养老服务的需求增加

- ✓ **社区养老服务设施：**老年人希望社区能够提供更加完善的养老服务设施，如老年活动中心、日间照料中心等。
- ✓ **社区养老服务网络：**老年人希望构建更加便捷的社区养老服务网络，实现居家养老与社区服务的无缝对接。例如，社区嵌入式养老模式将养老服务与社区生活紧密结合，为老年人提供贴近生活的服务。

银发经济观点分析：养老用品市场尚未被充分挖掘

◆ 养老用品市场未被充分挖掘，主要由于以下原因：一是产品供给不足，种类有限，难以满足老年人多样化、个性化需求，尤其在智能化、适老化产品方面存在明显缺口。二是市场需求未充分释放，部分老年人消费观念保守，对养老用品认知不足，消费意愿低；同时，市场对老年人潜在需求挖掘不够，未能有效激发其消费潜力。三是产业体系不完善，企业参与度低，品牌建设不足，市场监管薄弱，产品质量参差不齐，售后服务欠缺，影响消费者信任和购买积极性。总体来看，养老用品市场潜力巨大，但目前仍处于初级发展阶段，需要从产品创新、需求挖掘、产业完善、政策支持等多方面发力，才能充分释放市场潜力。



种类匮乏：全球老年用品SKU数量超过6万种，而中国老年用品SKU数量不到其1/10。目前中国老年用品主要覆盖老年人的基本生活需求，难以满足其休闲娱乐、医疗保健等高层次需求。

创新滞后：老年用品产业整体适老化水平、创新能力有待进一步提升。例如，针对老年人特殊需求的智能化、个性化产品供给不足。

消费观念保守：部分老年人消费观念较为保守，对养老用品的认知和接受度较低，更倾向于传统的养老方式。此外，一些老年人对产品价格较为敏感，注重产品质量和价格间的平衡。

需求挖掘不足：对老年人有效需求的挖掘还不充分，未能充分把握老年人对老年用品的需求及变化趋势。

企业参与度低：养老用品产业投入大、投资回报周期长，很多产品具有一定的福利性质，其经济效益低但社会效益好。这导致部分企业对进入养老用品市场的积极性不高。

品牌建设不足：目前中国老年用品市场缺乏知名品牌和龙头企业。品牌建设的不足使得消费者对产品的信任度较低，也限制了市场的进一步拓展。

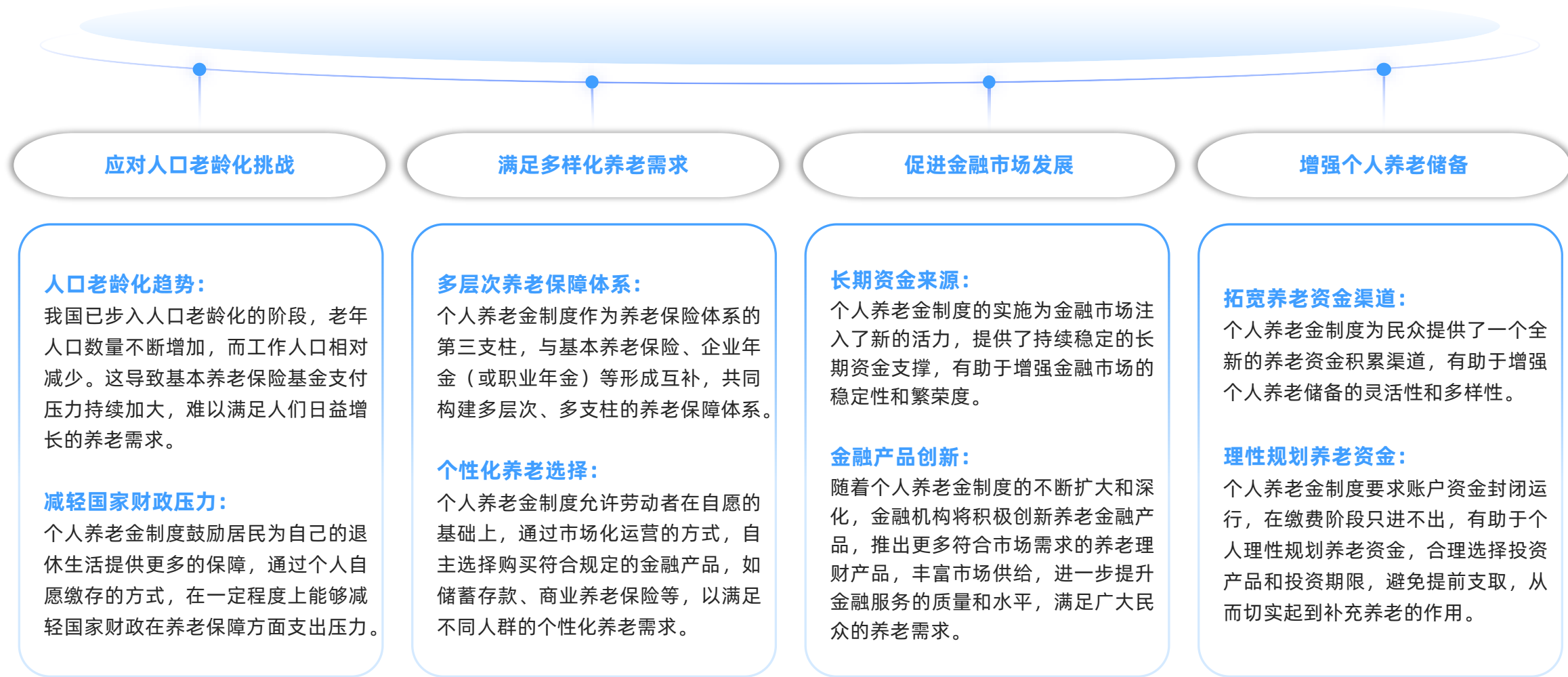
政策落实不足：虽然国家出台了一系列政策支持养老用品产业发展，但在具体落实过程中，部分政策的执行力度和效果有待加强。

市场监管不足：养老用品市场存在产品同质化严重、质量参差不齐等问题。市场监管的不足不仅影响了消费者的利益，也阻碍了市场的健康发展。

销售渠道有限：养老用品的销售渠道相对单一，主要集中在电商平台和部分线下专卖店。对于不熟悉网络购物的老年人来说，购买渠道不够便捷。

售后服务不足：养老用品的售后服务体系不够完善，部分产品在使用过程中出现问题后，消费者难以获得及时有效的售后支持。

银发经济观点分析：国家大力推广个人养老金制度



银发经济观点分析：日本银发经济对我国养老行业的借鉴意义



◆ 日本银发经济发展经验对我国借鉴意义显著，主要体现在三方面：一是搭建完善长期护理保险筹资机制，采用累进性费用增收、设计激励性筹资模式，同时拓展参保收益方式，纳入购买老年用品及居家改造。二是针对老年群体个性化需求匹配多元居所类型，配置复合化社区功能，构建产业生态圈，形成服务闭环与稳定盈利模式。三是提升老年用品类别丰富度与细分差异化，加强宣传，并借鉴日本通过保险制度为适老化改造提供资金支持，加大生活场景覆盖。

搭建完善的长期护理保险筹资机制， 拓展多元的参保收益方式

✓ 搭建可持续发展筹资机制

采用累进增收：运用累进性费用增收方式，阶段性提高个人费用承担比例，依据个人和家庭不同年收入，增加一定服务费用，缓解财政支出压力。

设计激励模式：构建更具激励性、可持续发展的筹资模式，关注不同收入人群缴费比例，达成制度动态平衡。

✓ 拓展参保收益方式

关注多元需求：我国长期护理保险基金目前主要用于支付基本护理服务，参保收益方式单一。可借鉴日本经验，在完善筹资机制后，逐步拓展参保收益方式。

纳入多元服务：将购买老年用品及实施居家改造纳入参保收益范围，加大对居家和社区养老的扶持。此举既能减轻老年人养老经济压力，又能激发老年用品等相关产业市场活力。

①

针对个性化需求匹配多元化服务， 构建产业生态圈

✓ 匹配多元居所类型

合理选址：依据老年群体需求特征，统筹交通、环境、服务等要素，科学进行社区选址，满足养老与生活需求。

复合功能配置：借鉴日本经验，适应老年人多元需求，配置复合化社区功能。针对老人不同身体机能状况，提供涵盖居住、文化、教育、医疗、护理等全方位的复合服务，满足其生活照料、医疗保健及精神追求。

✓ 构建产业生态圈与商业模式

构建产业生态圈是养老社区盈利关键举措，日本将其引入私立养老社区运营，形成服务闭环。

双维度构建：一是小循环，把护理、康复、医疗等刚需型服务纳入自身运营体系，自主运营创造竞争优势与利润增长点；二是大循环，将旅游、培训、金融等非刚需型服务交给专业服务商，通过动态评估筛选优化服务供给，构建完善养老服务生态系统，产出稳定现金流。

②

提升老年用品丰富度和细分差异化， 解决适老化改造的资金问题

✓ 提升老年用品供给与宣传

丰富产品类别：我国老年用品与服务尚处初期，供给有限，多满足基本需求。可参照日本经验，以提升老年人生活质量为出发点，设计丰富产品，增强安全性、卫生性、智能性，提升类别丰富度和细分差异化。

加强宣传引导：中国老年消费者对适老产品接受度受经济水平、消费观念等制约。政府、社会和厂商应加强对消费者的宣传教育。

✓ 支持适老化改造工作

解决资金难题：我国现有居住环境适老化改造需求大，单一财政投入难以为继，完全靠市场又不符合老年人收入实际。

借鉴日本经验：日本通过《介护保险法》为适老化改造提供资金。我国可设计完善长期护理保险制度等机制，为居家、社区、交通等场景的适老化改造提供资金支持。

③

本报告涉及的所有内容（包括但不限于数据、文字、图表等）均系行行查研究中心依据公开数据资料整理、编辑、绘制，研究中心力求但不保证该信息的准确性和完整性。受研究方法和数据获取资源的限制，本报告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担任何法律责任。本报告版权属于行行查，任何未经行行查书面授权许可，擅自使用本报告的内容进行复制、引用、传播、改编、出版等相关商业活动的行为，均涉嫌违反《中华人民共和国著作权法》和其他法律法规及有关国际公约的规定，行行查保留随时追究相关机构或人员法律责任的权利。如征得本公司书面许可后进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“行行查研究中心”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

All contents involved in this report (including but not limited to data, text, charts, etc.) are collated, edited and drawn by Hanghangcha based on publicly available data. Hanghangcha strives but does not guarantee the accuracy and completeness of the information. Due to the limitation of research methods and data access resources, this report is only provided to users as market reference, and the company does not assume any legal liability for the data or opinion. The copyright of this report belongs to Hanghangcha. Any unauthorized business use of our reports to copy, quote, spread, adaptation, publishing, are suspected of violating the law of the People's Republic of China copyright law. We retain the right to legal liability shall be investigated for relevant personnel or institutions at anytime. If the report is quoted or published with the permission of our company, it shall be used within the permitted scope and the source shall be indicated as "Hanghangcha Research Center", and no contradictory quotations, deletions or modifications shall be made to the report.

行行查研究中心